



Université Mohammed VI Polytechnique
Faculté de Gouvernance, Sciences Économiques et Sociales

Master 2
Analyse Économique et Politiques Publiques

Impact des transferts des migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants en Côte d'Ivoire

Une approche basée sur la méthode MODA

Mémoire présenté par

Mariam DIAKITE

Sous la direction de :

Pr. Touhami ABDELKHALEK

Pr. Dorothée BOCCANFUSO

Directeur du programme :

Pr. Aziz AJBILOU

Année universitaire 2025–2026

Dédicace

À ma famille,

*qui avez tout donné pour que je puisse aller loin,
qui avez cru en moi avant même que j'y croie moi-même,
et dont l'amour et les sacrifices ont été ma plus grande force.*

Ce travail est le fruit de votre dévouement.

Il vous appartient autant qu'à moi.

Avec tout mon amour et ma gratitude.

Remerciements

Au terme de ce travail, je tenais à exprimer ma sincère gratitude à Monsieur Hicham EL HABTI, Président de l'UM6P, à Monsieur Karim EL AYNAOUI, Doyen de la FGSES, et au Professeur Aziz AJBILOU, Directeur de notre Master, pour la confiance qu'ils m'ont accordée et les encouragements constants tout au long de cette formation.

J'exprime également ma reconnaissance à mes directeurs de mémoire, Professeur Touhami ABDELKHALEK et Professeure Dorothée BOCCANFUSO, pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce travail, la confiance qu'ils m'ont témoignée et la qualité de leurs orientations.

Mes remerciements vont également à l'ensemble du personnel de l'UM6P pour leur collaboration et leur appui, avec une mention spéciale aux professeurs du Master « Analyse Économique et Politiques Publiques ».

Je souhaite adresser des remerciements tout particuliers à Monsieur Mamadou Abdoulaye DIALLO, Post-doctorant, pour son accompagnement exceptionnel. Son suivi rigoureux et constant, depuis la définition du sujet jusqu'à la finalisation de ce travail, sa grande disponibilité et la pertinence de ses conseils ont largement contribué à l'aboutissement de ce travail.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à mes parents, Adama DIAKITE et Assata DIAKITE, pour leur soutien indéfectible, leurs sacrifices et les valeurs qu'ils m'ont transmises, qui ont été essentiels tout au long de mon parcours.

Enfin, je remercie chaleureusement mes amis pour leur présence, leur soutien et leurs encouragements.

À toutes et à tous, je témoigne ma vive reconnaissance.

Résumé

L'objectif de ce papier est d'évaluer l'impact des transferts des migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants en Côte d'Ivoire. A partir des deux vagues des données de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM), un indicateur de pauvreté multidimensionnelle a été construit à travers l'approche *Multiple Overlapping Deprivation Analysis* (MODA) suivant les différentes étapes de développement de l'enfant. Une stratégie quasi-expérimentale basée sur le score de propension (PSM) et la double différence (DD) a été utilisée sur un échantillon représentatif de 12 992 ménages pour identifier l'effet causal des transferts sur le bien-être des enfants. Les résultats descriptifs révèlent que plus de 66% des enfants sont privés dans au moins trois dimensions de la pauvreté multidimensionnelle. L'évaluation d'impact montre que globalement les transferts d'argent réduisent la pauvreté multidimensionnelle mais de façon modérée. Ces effets sont confirmés à travers une analyse de robustesse portant sur une même cohorte d'enfants, avec des impacts plus importants. L'étude fait ressortir également que l'impact des transferts évolue de manière non linéaire avec leur intensité. Ces résultats plaident pour une articulation des transferts migratoires avec des politiques publiques ciblées en matière de santé, d'eau, d'assainissement et de protection sociale, condition nécessaire à leur efficacité comme instrument de réduction de la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

Mots-clés : Transferts des migrants, pauvreté multidimensionnelle des enfants, MODA, PSM-DD, EHCVM.

Codes JEL : F24, I32, J13

Abstract

This paper evaluates the impact of migrant remittances on multidimensional child poverty in Côte d'Ivoire. Drawing on two waves of the Harmonized Household Living Conditions Survey (EHCVM), a multidimensional poverty index is constructed using the Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA) framework, tailored to distinct stages of child development. A quasi-experimental strategy combining propensity score matching (PSM) and difference-in-differences (DD) is applied to a representative sample of 12,992 households to identify the causal effect of remittances on child welfare. Descriptive findings indicate that more than 66% of children are deprived in at least three dimensions of multidimensional poverty. Impact estimates show that remittances reduce multidimensional child poverty overall, albeit moderately. These effects are confirmed through a robustness check on a matched cohort of children, yielding larger estimated impacts. The study further documents a non-linear relationship between remittances intensity and poverty outcomes. These results support integrating migrant remittances with targeted public policies in health, water, sanitation, and social protection as a necessary condition for their effectiveness as instruments for reducing multidimensional child poverty.

Keywords : Migrant remittances, children's multidimensional poverty, MODA, PSM-DD, EHCVM.

JEL Classification : F24, I32, J13

Sommaire

Résumé	iii
1 Introduction générale	1
2 Revue de littérature	4
2.1 Cadre théorique et conceptuel	4
2.2 Transferts des migrants et bien-être des enfants : enseignements empiriques	7
3 Données et méthodologie	10
3.1 Sources de données	10
3.2 L'approche MODA	12
3.3 Stratégie d'identification	17
4 Résultats	21
4.1 Analyse descriptive	21
4.2 Déterminants de la réception des transferts des migrants	27
4.3 Évaluation de la qualité de l'appariement	29
4.4 Impact global des transferts des migrants sur la pauvreté multidimensionnelle	34
4.5 Mesure de l'impact des transferts selon leur niveau d'intensité	36
5 Discussions	37
6 Conclusion et implications de politique publique	42
Références	44
Annexes	51

Liste des figures

1	Estimation du modèle logistique de réception de transferts de migrants . . .	29
2	Densité du score de propension après appariement : Cible 0–4 ans	31
3	Densité du score de propension après appariement : Cible 5–14 ans	32
4	Densité du score de propension après appariement : Cible 15–17 ans	33
A.1	Densité du score de propension après appariement : Enfants Panel	54

Liste des tableaux

1	Dimensions, indicateurs et critères de privation par groupe d'âge	14
2	Comparaison des ménages bénéficiaires et non bénéficiaires en 2018	22
3	Caractéristiques socio-démographiques des ménages bénéficiaires et non- bénéficiaires de transferts migratoires	22
4	Répartition des transferts monétaires selon le motif en 2018	23
5	Répartition des transferts monétaires selon l'origine en 2018	24
6	Indicateurs de privation multidimensionnelle des enfants non panel par groupe d'âge	26
7	Balancing test des échantillons appariés : Cible 0–4 ans	31
8	Balancing test des échantillons appariés : Cible 5–14 ans	32
9	Balancing test des échantillons appariés : Cible 15–17 ans	33
10	Test de la qualité de l'appariement : bénéficiaires vs non-bénéficiaires – enfants non panel	34
11	Impact des transferts sur les indicateurs de privation : enfants non panel .	36
A.1	Indicateurs de privation multidimensionnelle : Enfants Panel	51
A.2	Déterminants de la réception de transferts migratoires par groupe d'âge . .	52
A.3	Balancing test des échantillons appariés : Enfants Panel	53
A.4	Test de la qualité de l'appariement : bénéficiaires vs non-bénéficiaires – enfants panel	53
A.5	Impact des transferts sur les indicateurs de privation : enfants panel	54
A.6	Effet moyen du traitement sur les traités selon l'intensité des transferts . .	54

1 Introduction générale

La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, adoptée en 1989, affirme le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour assurer son développement physique, mental, spirituel, moral et social (Nations Unies, 1989). Elle consacre également son droit à la santé (art. 24), à l'éducation (art. 28) et à la protection contre toute forme de travail susceptible de compromettre son épanouissement (art. 32). L'adoption des Objectifs de développement durable (ODD) en 2015 s'est traduite par plusieurs engagements afin d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, faciliter l'accès à l'éducation de qualité et à des soins de santé essentiels, et la protection de l'enfant contre toute forme de violence (Nations Unies, 2015). Cependant, cet engagement universel se heurte à des réalités persistantes, particulièrement dans les pays en développement. En Afrique subsaharienne, plus de 50% des enfants souffrent d'au moins une privation sévère dans les dimensions fondamentales du bien-être de l'enfant (UNDP et OPHI, 2023). Le bien-être de l'enfant ne se résume pas uniquement au revenu du ménage dans lequel il évolue et dépend de multiples dimensions telles que l'accès à l'éducation, à la santé, à une alimentation adéquate ou encore à un environnement sain (de Neubourg et al., 2012; Mathebula et Alaba, 2024).

Traditionnellement, l'évaluation du bien-être et de la pauvreté des enfants s'est appuyée sur des approches monétaires, fondées sur le niveau de revenu ou de consommation des ménages. Bien que ces indicateurs soient utiles, ils apparaissent insuffisants pour appréhender la complexité des situations de privation, en particulier lorsqu'il s'agit des enfants (Pradhan et al., 2023). Ces constats ont conduit au développement d'approches multidimensionnelles de la pauvreté qui placent l'enfant au cœur de l'analyse et visent à mesurer directement les privations auxquelles il est exposé. C'est dans ce cadre que l'approche multidimensionnelle des privations *Multiple Overlapping Deprivation Analysis*

(MODA) a été développée par des chercheurs de l'UNICEF pour évaluer de manière fine les conditions de vie des enfants (de Neubourg et al., 2012).

Plusieurs facteurs sont susceptibles de réduire la pauvreté multidimensionnelle des enfants, parmi lesquels les politiques d'accès aux services sociaux de base et les transferts privés (Neubourg, 2014; UNDP et OPHI, 2023). Parmi ces derniers, les transferts de fonds des migrants agissent comme des revenus complémentaires susceptibles de desserrer les contraintes budgétaires et d'améliorer les conditions de vie des membres restés au pays (Nguyen et al., 2025), mais aussi l'accès des enfants à l'éducation (Ahmed et al., 2023; Feldmann, 2025), à la santé (Ramkissoon et Deonanan, 2023) et à une alimentation adéquate (Gosselin-Pali, 2025; Sulemana et al., 2023). En 2023, les flux de transferts de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont dépassé 656 milliards de dollars, dont 54 milliards de dollars à destination d'Afrique subsaharienne, soit un montant largement supérieur à l'aide publique au développement (Ratha et al., 2024).

Dans la littérature, plusieurs travaux empiriques ont tenté de mesurer l'impact des transferts sur le bien-être infantile. Ajefu et Ogebe (2021) ont montré, dans le contexte de cinq pays Africains, que les transferts internationaux entraînent une augmentation des dépenses consacrées à l'alimentation, aux biens durables, à l'éducation et à la santé. En revanche, Bayangos et Lubangco (2025) établissent dans le contexte des Philippines, que l'impact des transferts sur le bien-être à long terme reste limité, notamment en ce qui concerne la qualité du logement. Ces résultats contrastés témoignent de la complexité des mécanismes en jeu et soulignent la nécessité d'une approche qui appréhende simultanément l'ensemble des dimensions du bien-être infantile.

Cependant, la plupart de ces travaux se sont concentrés sur une seule dimension ou sur des indicateurs sectoriels isolés, sans adopter une approche intégrée des différentes dimensions du bien-être infantile. À notre connaissance, aucune étude n'a mobilisé la

méthodologie MODA pour évaluer l'impact des transferts de migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Ce manque de travaux empiriques ciblés limite la compréhension des mécanismes à l'œuvre et réduit la portée des recommandations de politique publique susceptibles d'en découler.

À l'instar des pays en développement, la Côte d'Ivoire constitue un cas d'étude particulièrement pertinent pour plusieurs raisons. Premièrement, elle reste à la fois un pays d'accueil et d'origine pour un bon nombre de personnes. Deuxièmement, elle comptait 1,1 million d'émigrés en 2021 (Organisation Internationale pour les Migrations, 2021), auxquels s'ajoute une forte migration interne alimentée par les disparités régionales et l'attractivité des pôles urbains. Cette dynamique migratoire s'accompagne d'envois de fonds considérables, estimés à environ 1 070 milliards de FCFA en 2018.¹ Également, la Côte d'Ivoire enregistre des niveaux élevés de pauvreté multidimensionnelle infantile. Selon Ministère du Plan et du Développement et UNICEF (2018), la grande majorité des enfants de moins de quatre ans souffre de privations en assainissement (74%), en logement (70,6%) et en santé (67,3%). En dépit de cette étude descriptive réalisée par Ministère du Plan et du Développement et UNICEF (2018), aucune étude ne s'est intéressée à évaluer l'impact des transferts des migrants sur la pauvreté multidimensionnelle en Côte d'Ivoire. Ce travail se propose dès lors de répondre à la question suivante : dans quelle mesure la réception de transferts de migrants par les ménages contribue-t-elle causalement à réduire les différentes formes de privation auxquelles les enfants sont confrontés ?

Cette étude présente un double intérêt, à la fois scientifique et politique. Du point de vue empirique, elle contribue à la littérature grandissante sur les impacts des transferts des migrants sur le bien-être. De plus, elle propose, à partir des données d'enquêtes récentes et représentatives, une évaluation rigoureuse de l'impact des transferts à travers une stratégie d'identification qui combine le score de propension (PSM), la double différence (DD) et

1. Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM), 2018 : calculs de l'auteure.

leur combinaison (PSM-DD), afin de contrôler à la fois le biais de sélection et les effets non observés invariants dans le temps. Les résultats obtenus permettent d'éclairer les décideurs publics sur le rôle que peuvent jouer les transferts des migrants dans la réduction de la pauvreté infantile et dans la conception de politiques sociales mieux ciblées.

Le reste de ce document est organisé comme suit. La section 2 présente une revue de la littérature théorique et empirique relative aux transferts et à la pauvreté multidimensionnelle des enfants. La section 3 décrit les sources de données et la méthodologie mobilisée. La section 4 est consacrée à la présentation des résultats économétriques. La section 5 propose une discussion approfondie des résultats. Enfin, la section 6 conclut et formule des implications de politique publique.

2 Revue de littérature

Cette section aborde le cadre théorique et conceptuel de la migration ainsi que les enseignements empiriques sur l'impact des transferts des migrants sur le bien-être des enfants.

2.1 Cadre théorique et conceptuel

Cette sous-section expose les fondements théoriques qui relient la migration, les transferts de fonds et la pauvreté multidimensionnelle des enfants, depuis les théories de la décision migratoire jusqu'à l'approche opérationnelle de la pauvreté multidimensionnelle.

2.1.1 Migration internationale et stratégies des ménages

Initialement formalisée par les théories néoclassiques, la migration est conçue comme une décision individuelle fondée sur les différentiels de salaires attendus entre le pays d'origine et de destination (Harris et Todaro, 1970). Cette approche postule que les

individus comparent leur situation actuelle aux perspectives offertes par les marchés du travail étrangers et migrent lorsque les gains espérés excèdent les coûts associés.

À l’opposé, la Nouvelle Économie de la Migration du Travail (NELM), développée par Stark (1993), replace le ménage au centre de la décision migratoire. La migration y apparaît comme une stratégie collective pour diversifier les risques, lisser la consommation et pallier les imperfections des marchés du travail, du crédit et de l’assurance (Stark et Bloom, 1985). Les transferts de fonds envoyés par les migrants constituent dans ce cas un élément intentionnel d’un contrat implicite intra-familial, qui soutient à la fois la consommation et l’investissement au profit des membres restés au pays.

Cette perspective est enrichie par Piguet (2010), qui insiste sur l’intention de migrer comme résultant d’un arbitrage entre contraintes structurelles et capacités d’action des ménages. Le processus décisionnel intègre ainsi des facteurs économiques, sociaux, familiaux et institutionnels. Cependant, si les transferts renforcent les capacités économiques des ménages, la migration modifie leur organisation interne, notamment via la migration parentale qui génère des coûts sociaux particulièrement pour les enfants restés au pays d’origine (De Haas, 2010).

2.1.2 Migration et hétérogénéité des effets

Les transferts des migrants constituent un levier d’assouplissement des contraintes de liquidité auxquelles font face les ménages, et leur permettent d’accroître les dépenses en biens essentiels ainsi que les investissements en capital humain (Yang, 2011). Toutefois, l’ampleur et la régularité de ces flux varient sensiblement selon le type de migration et le degré d’installation du migrant dans le pays d’accueil. Cette hétérogénéité implique des effets différenciés en fonction de la durée écoulée depuis le départ et des canaux de transfert mobilisés (Adams et Page, 2005).

Cette relation entre migration et bien-être des ménages d'origine est cependant loin d'être univoque. Si les transferts monétaires améliorent les ressources disponibles, la migration entraîne simultanément des coûts non monétaires liés à l'absence du migrant, notamment lorsque celui-ci est parent d'enfants restés au pays. Par le biais d'une réduction du temps parental consacré à la supervision et à l'encadrement des enfants, cette absence peut dégrader certaines dimensions du bien-être infantile indépendamment du niveau de revenu du ménage (Antman, 2012). Ces effets contradictoires justifient le recours à une approche multidimensionnelle pour saisir l'effet net des transferts sur la pauvreté des enfants.

2.1.3 Pauvreté multidimensionnelle et approche par les capacités

Longtemps, les économistes ont appréhendé la pauvreté à travers une approche unidimensionnelle centrée sur le revenu ou la consommation (Chakravarty, 1990 ; Ravallion, 1992). Ces mesures monétaires, bien que pratiques, se révèlent inadéquates pour capturer l'ensemble des privations qui affectent les individus, notamment les enfants dont le bien-être dépend de multiples dimensions interdépendantes. De fait, l'approche multidimensionnelle, théorisée par Nussbaum et Sen (1993) et Sen (1987), permet de redéfinir la pauvreté comme une privation de capacités essentielles telles que la capacité à se nourrir correctement, à être en bonne santé, à accéder à l'éducation, à vivre dans un environnement sûr. Cette perspective dépasse l'insuffisance de ressources pour se concentrer sur les opportunités effectives de réaliser des fonctionnements valorisés socialement. Alkire et Foster (2011) formalisent cette vision à travers un cadre axiomatique qui mesure les privations multiples selon une approche de décomposition par dimensions et intensité, permettant d'identifier à la fois l'incidence et la profondeur des privations au sein des populations.

L'UNICEF opérationnalise ce cadre à travers une approche (MODA), qui mesure les

privations cumulées dans des dimensions clés telles que la nutrition, la santé, l'éducation, l'eau, le logement et la protection, selon des seuils adaptés à l'âge (de Neubourg et al., 2012 ; Neubourg, 2014). Le MODA se distingue des indices généraux de pauvreté multidimensionnelle par son focus spécifique sur les besoins des enfants.

2.2 Transferts des migrants et bien-être des enfants : enseignements empiriques

La migration internationale, souvent analysée comme une stratégie économique qui vise à améliorer le niveau de vie des ménages (De Haas, 2010 ; Stark, 1993), génère toutefois des coûts sociaux liés à la recomposition familiale, susceptibles d'influencer le bien-être des enfants laissés derrière. La littérature empirique met en évidence des effets hétérogènes de la migration via les transferts sur plusieurs dimensions du bien-être. Cette sous-section passe en revue les principaux résultats empiriques relatifs aux effets des transferts sur les conditions de vie des ménages, ainsi que sur la santé, l'éducation et la nutrition qui constituent des dimensions importantes du bien-être.

2.2.1 Transferts et conditions de vie du ménage

Les transferts de fonds des migrants représentent une source de revenu substantielle pour les ménages du pays d'origine (Nguyen et al., 2025). Ils contribuent significativement à l'amélioration du pouvoir d'achat des bénéficiaires, ce qui permet une meilleure satisfaction des besoins fondamentaux tels que l'alimentation et les soins de santé (Islam et al., 2019). Cette injection de ressources se traduit également par des dépenses accrues liées au logement. Jayaweera et Verma (2023), à partir d'une méthode basée sur le score de propension (PSM) dans le cas du Sri Lanka, montrent que les ménages bénéficiaires de transferts présentent de meilleures conditions de logement que les non-bénéficiaires, avec des dépenses plus élevées et une meilleure accessibilité financière.

Cependant, la littérature nuance fortement la portée transformative de ces flux. D’une part, leur impact sur la qualité structurelle durable du logement (matériaux de construction, superficie, solidité) reste limité (Jayaweera et Verma, 2023). En effet, une part importante des fonds, en particulier dans les ménages les plus pauvres, est allouée à la consommation courante, y compris l’accès à l’eau potable (Tsafack et Djeunankan, 2021), sans réorientation significative vers des investissements productifs à long terme (Bayangos et Lubangco, 2025).

D’autre part, leur capacité à financer des équipements domestiques essentiels est également avérée. Une étude approfondie menée en Thaïlande et au Vietnam sur les infrastructures d’assainissement montre que les transferts augmentent significativement la probabilité pour les ménages ruraux de disposer de toilettes améliorées (Nguyen et al., 2025). Dans la même perspective, Hasibuan et Hartono (2024) confirment, à partir d’un indice multidimensionnel de pauvreté énergétique en Indonésie, que les transferts des migrants réduisent significativement la privation énergétique des ménages, notamment par l’amélioration de l’accès à l’électricité. Ces études confirment le rôle important des flux privés dans le renforcement des conditions matérielles de vie.

2.2.2 Transferts, santé et nutrition des enfants

Au-delà de leur contribution à l’amélioration des conditions de logement et de l’accès aux services énergétiques, les transferts des migrants sont susceptibles d’agir plus directement sur le capital humain des enfants, en particulier sur leur état nutritionnel et sanitaire. La littérature récente met en évidence des effets contrastés, dont le signe et l’intensité dépendent fortement du contexte, de l’horizon temporel et des mécanismes familiaux à l’œuvre.

Un premier canal direct et prévisible repose sur l’amélioration de la sécurité alimentaire. À partir d’une enquête menée auprès de ménages agricoles au Nigeria, Babatunde (2018)

montre que les transferts monétaires augmentent significativement l'apport calorique des bénéficiaires à travers une meilleure accessibilité alimentaire. Toutefois, l'étude ne relève aucun impact notable sur la qualité du régime (diversité alimentaire) ni sur l'état nutritionnel des enfants. Les transferts servent avant tout à satisfaire les besoins caloriques essentiels, sans forcément améliorer la qualité nutritionnelle ou la santé des enfants. Cela rejoint les études de Ramkissoo et Deonanan (2023) dans 122 pays en développement, qui confirment que les transferts réduisent significativement la mortalité infantile, mais uniquement pour les maladies diarrhéiques, sans réel effet sur les causes qui nécessitent des interventions médicales spécialisées.

2.2.3 Transferts et éducation des enfants

Une autre dimension du bien-être des enfants susceptible d'être influencée par les transferts est l'éducation. La littérature empirique s'accorde sur le rôle positif des transferts des migrants dans l'amélioration des trajectoires éducatives des enfants, principalement via le relâchement des contraintes de liquidité et une hausse de l'investissement éducatif au niveau du ménage (UNESCO, 2018).

À l'échelle macro-économique, Feldmann (2025) confirme cet effet sur un panel de 122 pays, avec une augmentation des taux d'inscription au primaire et secondaire, via des canaux comme les dépenses éducatives accrues et la réduction du travail des enfants. Toutefois, Tello et Sánchez (2025) trouvent que les transferts influencent davantage les choix éducatifs que les résultats scolaires effectifs. Ils montrent dans le cas de l'Équateur que les transferts favorisent l'accès à des établissements privés et permettent de couvrir les frais de scolarité, sans gains systématiques en années de scolarité ou réduction du retard scolaire, ce qui souligne un effet plus marqué sur les *inputs* (dépenses) que sur les *outputs* (acquis).

Par ailleurs, Qiu et al. (2024) établissent des effets négatifs de la migration parentale sur les dimensions familiales et psychosociales. Ces auteurs montrent, pour le cas de la Chine, que les transferts atténuent partiellement ces effets négatifs par l’augmentation de l’investissement éducatif, mais cela ne protège pas pour autant la performance académique.

Dans l’ensemble, les transferts des migrants exercent un effet favorable mais conditionnel et hétérogène sur l’éducation des enfants. Ils soutiennent l’inscription et l’investissement, mais peinent à compenser pleinement l’absence parentale.

3 Données et méthodologie

3.1 Sources de données

Cette étude s’appuie sur les données issues des deux premières éditions de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) menées en Côte d’Ivoire, respectivement en 2018/2019 et en 2021/2022. L’EHCVM est une initiative de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), avec l’appui technique et financier de la Banque mondiale. Ces enquêtes menées par l’Institut National de la Statistique (INS) ont pour objectif principal de produire des indicateurs de pauvreté et de conditions de vie harmonisés et comparables entre les pays membres de l’Union, selon une méthodologie standardisée commune (Institut National de la Statistique (INS), 2018). Le questionnaire ménage multithématique sur lequel repose l’EHCVM couvre les dimensions essentielles du bien-être des ménages et des individus, notamment les conditions de logement, l’accès aux services de base, la santé, l’éducation, l’emploi et les transferts reçus. Sa structure est restée quasi-identique entre les deux vagues, ce qui garantit la comparabilité temporelle des informations collectées et permet une analyse longitudinale rigoureuse.

3.1.1 L'enquête EHCVM 2018 : la base de référence

La première édition de l'EHCVM en Côte d'Ivoire s'est déroulée entre septembre 2018 et juillet 2019. La collecte des données a été organisée en deux passages successifs afin de prendre en compte les variations saisonnières de la consommation des ménages. Le plan de sondage adopté est un sondage stratifié et tiré à deux degrés. Au premier degré, des zones de dénombrement (ZD), issues du recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) de 2014, ont été tirées de manière aléatoire à probabilité inégale au sein de chacune des 33 régions administratives que compte le pays. Au second degré, un tirage systématique de 12 ménages est effectué dans chaque ZD sélectionnée. L'échantillon initial ciblait 13 008 ménages. Après apurement et traitement des données, 12 992 ménages ont été retenus pour l'analyse. Les résultats issus de cette enquête sont représentatifs au niveau national, par milieu de résidence (urbain/rural) et par région administrative.

3.1.2 L'EHCVM 2021 : une enquête de panel

La deuxième édition de l'EHCVM a été réalisée entre novembre 2021 et juillet 2022. Sa spécificité méthodologique réside dans la mise en place d'un panel de grappes fondé sur l'échantillon de 2018. Les mêmes ZD tirées lors de la première vague ont été reconduites, et une phase préalable de cartographie et de dénombrement a été organisée pour localiser les ménages précédemment enquêtés. Tous les ménages de 2018 retrouvés dans leur grappe d'origine ont été systématiquement réinterrogés, complétés si nécessaire par de nouveaux ménages tirés dans la même ZD afin d'atteindre la taille cible de 12 ménages par grappe. L'échantillon total est resté fixé à 13 008 ménages, dont 12 965 ont été retenus après apurement et traitement des données.

Afin de permettre une analyse longitudinale de l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, les deux vagues de l'EHCVM ont été appariées à partir

de l'identifiant unique des ménages, qui assure une correspondance univoque entre les ménages enquêtés en 2018 et ceux retrouvés en 2021. Cette procédure d'appariement a permis de constituer un échantillon panel qui représente environ 60% de l'échantillon initial de 2018, soit un taux d'attrition d'environ 40% entre les deux vagues.

L'échantillon panel final est ainsi structuré autour de trois groupes d'enfants définis selon les tranches d'âge retenues par l'approche MODA à savoir les enfants de 0 à 4 ans, de 5 à 14 ans et de 15 à 17 ans, observés au niveau du ménage. Un quatrième groupe, composé des enfants âgés de 6 à 14 ans observés au niveau individuel, est constitué à des fins de vérification de la robustesse des résultats. En effet, l'analyse principale repose sur une observation au niveau du ménage, ce groupe permet donc de tester la sensibilité des estimations à un changement d'unité d'observation. Si les effets identifiés au niveau ménage se confirment à l'échelle individuelle, cela renforce la validité des conclusions et montre qu'elles ne sont pas tributaires de ce choix méthodologique. La tranche d'âge 6–14 ans se prête particulièrement à cet exercice, dans la mesure où ces enfants sont identifiables d'une vague à l'autre au sein de l'EHCVM, ce qui rend leur suivi individuel entre 2018/2019 et 2021/2022 suffisamment fiable.

Les données ainsi construites servent de support à la mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants selon l'approche MODA, dont la méthodologie est présentée dans la section suivante.

3.2 L'approche MODA

3.2.1 Présentation de l'approche MODA

La mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants dans cette étude repose sur l'approche MODA (*Multiple Overlapping Deprivation Analysis*), développée par des chercheurs de l'UNICEF (de Neubourg et al., [2012](#)). Contrairement aux approches moné-

taires traditionnelles qui appréhendent la pauvreté à travers le seul prisme du revenu ou de la consommation, l'approche MODA adopte une conception multidimensionnelle du bien-être de l'enfant et s'intéresse aux privations que celui-ci subit simultanément dans plusieurs dimensions essentielles de sa vie. Cette approche présente deux caractéristiques fondamentales. D'une part, elle est centrée sur l'enfant en tant qu'unité d'analyse et reconnaît que les besoins ainsi que les droits des enfants varient selon leur âge et leur stade de développement. D'autre part, elle permet d'identifier les chevauchements de privations, c'est-à-dire les enfants qui souffrent simultanément de plusieurs manques, ce que ne permettent pas les approches unidimensionnelles (de Neubourg et al., [2012](#)).

Conformément à la charte des droits des enfants, la Côte d'Ivoire considère comme enfant tout humain âgé de moins de 18 ans. Pour mieux tenir compte de leurs besoins spécifiques et différenciés au cours du processus de leur développement, l'analyse est conduite séparément pour trois groupes d'âge aux besoins distincts dont les enfants de 0 à 4 ans, de 5 à 14 ans et de 15 à 17 ans. Une cohorte d'enfants âgés de 6 à 14 ans en 2018/2019² a été construite et suivie dans le temps pour des besoins d'analyse de la robustesse.

3.2.2 Dimensions, indicateurs et critères de privation

Cette étude s'inspire de l'analyse des privations multiples des enfants en Côte d'Ivoire élaborée par le Ministère du Plan et du Développement en 2018. Compte tenu des données disponibles, sept dimensions de privation sont retenues dans cette étude (Tableau 1). Il s'agit de l'assainissement, de l'eau, du logement, de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de l'information et de la protection contre le travail des enfants. Les dimensions d'assainissement, d'eau, de logement, d'éducation et de protection contre le travail des enfants sont opérationnalisées conformément aux critères standards tels que décrits par l'UNICEF

2. Ces enfants ont 9-17 ans en 2021/2022

(2012). Trois dimensions ont nécessité des adaptations. Pour la santé, les indicateurs de vaccination et d'assistance à l'accouchement ont été remplacés par l'accès à une assurance maladie et l'utilisation de la moustiquaire MILDA.³ Pour l'information, seul l'indicateur de disponibilité de dispositifs d'informations a été retenu faute de données sur les connaissances VIH-SIDA. Pour la nutrition, les mesures anthropométriques standards n'étant pas disponibles dans l'EHCVM, des proxys d'insécurité alimentaire issus de l'échelle de la faim (FIES) ont été utilisés, avec une règle d'agrégation par intersection (un enfant n'étant considéré comme privé que s'il l'est sur l'ensemble des cinq indicateurs simultanément).

Table 1. Dimensions, indicateurs et critères de privation par groupe d'âge

Dimensions	Indicateurs	Critère de privations	Cibles		
			0–4 ans	5–14 ans	15– 17 ans
Assainissement	Type de toilettes	L'enfant est privé si les toilettes auxquelles a accès son ménage sont des installations sanitaires non améliorées.	X	X	X
	Partage des toilettes	L'enfant est privé s'il vit dans un ménage où les toilettes sont partagées avec au moins un autre ménage.	X	X	X
Eau	Source d'eau	L'enfant est privé s'il vit dans un ménage où la source d'eau de boisson est non améliorée.	X	X	X
	Temps d'accès à l'eau potable	L'enfant est privé s'il vit dans un ménage où la source d'eau n'est pas dans le ménage et/ou le temps pour aller chercher l'eau et revenir est supérieur à 30 minutes.	X	X	X
Logement	Surpeuplement	L'enfant est privé s'il vit dans un ménage en surpeuplement (plus de 2 personnes par chambre à coucher, excluant cuisine et salle à manger).	X	X	X
	Toits, murs et sols	L'enfant est privé s'il vit dans un ménage dont le logement est construit principalement avec des matériaux rudimentaires (toit, murs et sol).	X	X	X

(suite page suivante)

3. MILDA : Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'Action constitue une mesure d'accès à la protection préventive contre le paludisme.

(suite)

Dimensions	Indicateurs	Critère de privations	Cibles		
			0–4 ans	5–14 ans	15– 17 ans
	Disponibilité de l'électricité	L'enfant est privé s'il vit dans un ménage qui ne dispose pas de l'électricité, quelle que soit la source.	X	X	X
Santé	Assurance maladie	L'enfant est privé s'il vit dans un ménage ne disposant d'aucune assurance maladie, quelle qu'en soit la forme.	X	X	X
	MILDA	L'enfant est privé s'il ne dort pas sous une Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'Action (MILDA).	X	X	X
Nutrition¹	Nourriture saine	Au cours des 12 derniers mois, le ménage n'a pas pu consommer une nourriture saine et nutritive par manque de ressources.	X		
	Nourriture variée	Au cours des 12 derniers mois, le ménage a consommé une nourriture peu variée par manque de ressources.	X		
	Disponibilité alimentaire	Au cours des 12 derniers mois, le ménage n'avait plus de nourriture par manque de ressources.	X		
	Avoir faim	Au cours des 12 derniers mois, des membres du ménage ont eu faim sans pouvoir manger par manque de ressources.	X		
	Journée sans manger	Au cours des 12 derniers mois, des membres du ménage ont passé une journée entière sans manger par manque de ressources.	X		
Éducation	Fréquentation scolaire	L'enfant de 5 à 17 ans est privé s'il ne fréquente pas l'école.		X	X
	Réussite scolaire	L'enfant de 13–15 ans est privé s'il n'a pas atteint le niveau secondaire 1 ^{er} cycle; l'enfant de 16–17 ans est privé s'il n'a pas atteint le niveau secondaire 2 ^e cycle.		X	X
Information	Disponibilité de dispositifs d'information	L'enfant est privé s'il vit dans un ménage ne disposant d'aucun des équipements suivants : télévision, radio, téléphone portable ou ordinateur.			X

Protection contre le travail des enfants	Travail des enfants	L'enfant de 5 à 11 ans est privé s'il a effectué au moins 1h d'activité économique ou 28h de travail ménager/semaine. L'enfant de 12 à 14 ans est privé s'il a effectué au moins 14h d'activité économique ou 28h de travail ménager/semaine.		X
---	---------------------	---	--	---

Note : X indique que l'indicateur est applicable au groupe d'âge concerné.

¹ Indicateurs FIES utilisés en substitution aux indicateurs anthropométriques non disponibles dans l'EHCVM.

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

3.2.3 Construction du score de privation et seuils MODA

Le score de privation MODA est construit en deux étapes. Dans un premier temps, pour chaque dimension, un enfant est considéré comme privé dans cette dimension dès lors qu'il est privé d'au moins un des indicateurs qui la composent. Dans un second temps, le score MODA global est calculé comme le nombre total de dimensions dans lesquelles l'enfant est simultanément privé, sur l'ensemble des dimensions applicables à son groupe d'âge. Des poids égaux sont attribués à chaque dimension, conformément à l'approche standard de l'UNICEF.

Le seuil généralement retenu dans la littérature MODA est celui du tiers des dimensions. Dans notre cas, un enfant est donc considéré comme multidimensionnellement pauvre s'il est privé dans au moins trois dimensions. Afin d'évaluer la robustesse des résultats à ce choix, une analyse de sensibilité est conduite à travers la variation du seuil de privation. Des seuils alternatifs sont ainsi testés, fixant successivement le nombre minimal de dimensions requises à trois, quatre, cinq et six. Cette technique permet donc d'apprécier la sensibilité des résultats au seuil.

3.3 Stratégie d'identification

3.3.1 Approche méthodologique générale

La littérature sur les techniques d'évaluation d'impact ex-post s'est accumulée au cours des 25 dernières années. Deux grandes méthodes sont issues de ces recherches à savoir la méthode expérimentale et la méthode quasi-expérimentale. De ce fait, évaluer l'impact des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle peut être conduite à travers ces deux méthodes. Toutefois, compte tenu de la nature des données dont nous disposons, une approche quasi-expérimentale et plus précisément la méthode d'appariement sur le score de propension (PSM) et la double différence (DD) s'avère nécessaire. La combinaison de ces deux méthodes permet en effet de renforcer la solidité de l'estimation du contrefactuel (White et Sabarwal, 2014). Le PSM permet de s'assurer que les ménages bénéficiaires et non bénéficiaires de transferts soient suffisamment semblables pour que la comparaison ait un sens. Dans ces conditions, le score de propension peut être utilisé pour la correction d'éventuels biais de sélection (Lecocq, 2014). Quant à la double différence, elle permet la sélection sur les observables ainsi qu'une sélection invariante dans le temps sur les inobservables (Smith et Todd, 2005). L'association de ces deux méthodes garantit que seuls des ménages comparables dans le groupe de contrôle sont pris en compte dans l'estimation de l'effet du traitement (Smith et Todd, 1997). Ainsi, la combinaison de l'appariement et de la double différence (PSM-DD) permet, outre les caractéristiques observables, de contrôler au moins les caractéristiques non observées qui sont constantes dans le temps pour les deux groupes.

Puisque nous recourons à une méthode quasi-expérimentale, il convient de rappeler le potentiel biais de sélection inhérent à la méthode. Ce biais fait référence à la sélection des bénéficiaires lorsque celle-ci n'est pas basée sur une randomisation (Shadish et al., 2002).

Le biais de sélection est une menace pour la validité interne qui sous-entend un lien de causalité entre les variables indépendantes et les variables de résultats. La méthode PSM-DD est fréquemment utilisée pour tenir compte des biais qui résulteraient des tendances non parallèles (Ryan et al., 2015). Cependant, des travaux plus récents ont montré que cette approche n'élimine pas toujours les biais (Chabé-Ferret, 2015 ; Lindner et McConnell, 2019). De fait, il est recommandé aux utilisateurs de la méthode PSM-DD de présenter les estimations des doubles différences non ajustées et ajustées en fonction du score de propension pour juger de la dépendance des résultats à une spécification (Lindner et McConnell, 2019). Dans cette étude, nous présentons les résultats de trois principales spécifications dont le PSM simple, la double différence simple (DD) et la combinaison PSM-DD.

3.3.2 L'appariement par le score de propension (PSM)

Le score de propension est la probabilité qu'un ménage reçoive au moins un transfert de migrant conditionnellement aux caractéristiques observables X . Cette probabilité est définie comme suit :

$$p(X) = P(T = 1 \mid X), \quad (1)$$

$$Y^0 \perp T \mid X \implies Y^0 \perp T \mid p(X). \quad (2)$$

Où T est la variable de traitement binaire valant 1 si le ménage a reçu au moins un transfert, qu'il soit d'origine interne ou internationale, et 0 sinon. Y^0 désigne le résultat potentiel en l'absence de traitement soit l'indice MODA agrégé ou l'une de ses dimensions de bien-être. La propriété d'équilibrage (2), établie par Rosenbaum et Rubin (1983), garantit que le score de propension résume l'ensemble de l'information contenue dans X

pour l’assignation au traitement. Ce score est estimé à partir d’un modèle de régression logistique sous la forme :

$$\hat{p}(X) = \frac{\exp(f(X))}{1 + \exp(f(X))} \quad (3)$$

L’estimation est conduite séparément pour chaque groupe d’âge cible (0–4 ans, 5–14 ans et 15–17 ans). Les covariables retenues et conformes à celles utilisées dans la littérature empirique (Abdulai et al., 2017; Jayaweera et Verma, 2023) sont le sexe de l’enfant, le sexe du chef de ménage, l’âge du chef de ménage, le niveau d’éducation du chef de ménage, le statut matrimonial du chef de ménage, la taille du ménage, le statut d’occupation du logement, le statut d’activité du chef de ménage, la zone géographique et le milieu de résidence.

La qualité de l’appariement est vérifiée à l’aide du test d’équilibre des covariables, le balancing test avant et après appariement ainsi que par l’inspection visuelle des graphiques de densité des scores de propension et des graphiques de support commun. Deux algorithmes d’appariement sont mis en œuvre afin de tester la robustesse des résultats à l’appariement aux cinq plus proches voisins et l’appariement par la méthode du noyau (Caliendo et Kopeinig, 2008). Dans les deux cas la condition de support commun est imposée afin d’exclure les ménages traités dont le score de propension se situe en dehors de la zone de chevauchement avec les ménages non traités.

3.3.3 La méthode des doubles différences (DD)

La méthode de la double différence compare les différences de résultats au fil du temps entre une population bénéficiaire de transferts et une autre qui n’en bénéficie pas. Elle suppose que l’hétérogénéité non observée de la participation est présente mais que ces facteurs sont invariants dans le temps. L’estimateur de la double différence s’écrit :

$$DD = E(Y_{i1} - Y_{i0} \mid T_i = 1) - E(Y_{i1} - Y_{i0} \mid T_i = 0) \quad (4)$$

L'une des différences doit permettre d'éliminer les différences systématiques entre le groupe des bénéficiaires et les autres et l'autre différence doit permettre d'éliminer l'évolution temporelle, supposée identique pour les deux groupes en l'absence de traitement. Le modèle à estimer se présente comme suit :

$$Y_{it} = \alpha + \delta T_i \times Post_t + \beta T_i + \gamma Post_t + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

Où le coefficient δ donne l'estimateur de la double différence. Les variables $Post_t$ et T_i sont incluses séparément pour tenir compte d'un effet potentiel du temps qui passe et d'un effet qui provient du fait d'être ou non bénéficiaire de transferts. Y_{it} désigne la variable de résultat du ménage i à la période t , soit le score MODA global ou le taux de privation par dimension.

3.3.4 La combinaison PSM-DD

La combinaison PSM-DD consiste à appliquer l'estimateur des doubles différences sur l'échantillon apparié issu du PSM. Cette approche permet de contrôler simultanément les biais liés aux caractéristiques observables via le PSM et les biais liés aux facteurs inobservables invariants dans le temps via la DD (Smith et Todd, 1997). Formellement, l'estimateur PSM-DD s'écrit :

$$\hat{\delta}^{PSM-DD} = \frac{1}{n_T} \sum_{i \in T} \left[(Y_{i,2021} - Y_{i,2018}) - \sum_{j \in C} w_{ij} (Y_{j,2021} - Y_{j,2018}) \right] \quad (6)$$

Où n_T est le nombre de ménages traités dans le support commun, w_{ij} sont les poids d'appariement attribués aux ménages non traités j appariés au ménage traité i , et T et C

désignent respectivement les groupes de traitement et de contrôle.

4 Résultats

4.1 Analyse descriptive

4.1.1 Caractéristiques des ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires

Le tableau 2 présente les caractéristiques sociodémographiques des ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires de transferts migratoires en 2018. Il ressort que 53,5% des ménages vivant en milieu urbain ont reçu des transferts, bien que la majorité des bénéficiaires (52,7%) résident en milieu rural. Par ailleurs, les ménages sont en majorité dirigés par des hommes (81,9%), mais parmi les bénéficiaires, 31,4% sont dirigés par une femme. De même, plus de la moitié des ménages bénéficiaires sont dirigés par un chef non marié (58,4%), et 52,8% d'entre eux sont propriétaires de leur logement. S'agissant du niveau d'éducation, les ménages dont le chef n'a aucun niveau d'instruction formel constituent la catégorie la plus représentée parmi les bénéficiaires (50,4%). Enfin, la répartition géographique révèle que plus de la moitié des ménages des zones Centre (59,3%) et Est (51,8%) ont bénéficié de transferts.

Le tableau 3 présente les statistiques descriptives des variables quantitatives. On observe que les chefs de ménage bénéficiaires sont en moyenne plus âgés (44 ans) que ceux des ménages non-bénéficiaires (41 ans), une différence statistiquement significative au seuil de 1%. En revanche, la taille des ménages bénéficiaires (4,6 membres en moyenne) reste légèrement inférieure à celle des ménages non-bénéficiaires (4,7 membres), une différence faiblement significative au seuil de 10% seulement.

Table 2. Comparaison des ménages bénéficiaires et non bénéficiaires en 2018

		Bénéficiaires (N = 4 587)	Non-bénéficiaires (N = 8 405)	Ensemble (N = 12 992)	% bénéficiaires (35,3 %)
Genre du chef de ménage	Masculin	68,6	89,1	81,9	45,7
	Féminin	31,4	10,9	18,1	61,8
Niveau d'éducation du chef de ménage	Aucune éducation	50,4	60,1	56,7	40,8
	Primaire	19,1	18,7	18,8	46,6
	Secondaire et plus	30,6	21,2	24,5	57,3
Statut matrimonial du chef de ménage	Marié / en union	41,6	26,8	32,0	59,7
	Non marié	58,4	73,2	68,0	39,3
Statut d'occupation du logement	Propriétaire	52,8	46,4	48,7	49,7
	Locataire / autre	47,2	53,6	51,3	42,2
Milieu de résidence	Urbain	47,3	36,9	40,6	53,5
	Rural	52,7	63,1	59,4	40,7
Zone géographique	Nord	17,8	19,7	19,0	43,1
	Ouest	13,7	15,7	15,0	42,0
	Est	14,3	11,9	12,7	51,8
	Centre	21,7	14,1	16,8	59,3
	Sud	32,5	38,6	36,5	40,9

Note : Les valeurs sont exprimées en pourcentage. La colonne « % bénéficiaires » indique la part de ménages bénéficiaires au sein de chaque catégorie.

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

Table 3. Caractéristiques socio-démographiques des ménages bénéficiaires et non-bénéficiaires de transferts migratoires

	Bénéficiaires (N = 4 587)	Non-bénéficiaires (N = 8 405)	Différence	Ensemble (N = 12 992)
Âge moyen du chef de ménage	43,7	41,1	+2,6***	42,0
Taille moyenne du ménage	4,6	4,7	-0,1*	4,6

Note : Différence = Bénéficiaires – Non-bénéficiaires. T-test de différence de moyennes.

*** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,1$.

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

4.1.2 Statistiques descriptives des transferts monétaires

L'analyse descriptive des transferts présentée dans le tableau 4 révèle que le soutien courant constitue de loin le principal motif des transferts. En 2018, il représente 70,4% des transferts en nombre et 72,0% du montant total, soit 770 milliards de FCFA sur un total de 1 070 milliards. Au-delà du soutien courant, les transferts à vocation sociale occupent une place non négligeable dans les envois. En 2018, la santé représente 7,7% des transferts et constitue 5,9% du montant total (62,8 milliards FCFA), tandis que l'éducation représente 5,9% pour 6,6% du montant total (70,5 milliards FCFA). Toutefois, les transferts à destination productive (agriculture et entreprise) demeurent marginaux, avec une part comprise entre 0,8% et 2,2% des transferts en nombre et entre 1,2% et 1,4% du montant total. Ce constat montre que les transferts monétaires sont davantage mobilisés pour répondre à des besoins immédiats que pour financer des activités génératrices de revenus.

Table 4. Répartition des transferts monétaires selon le motif en 2018

Motif du transfert	Part selon le motif	Montant total (milliards FCFA)	Montant moyen (FCFA)	Part du montant
Éducation	5,9%	70,5	359 671	6,6%
Santé	7,7%	62,8	246 635	5,9%
Consommation	70,4%	770,0	331 376	72,0%
Agriculture	2,2%	12,9	177 707	1,2%
Entreprise	1,2%	14,4	375 036	1,3%
Événements	3,4%	17,8	156 863	1,7%
Terrain	0,1%	2,6	711 681	0,2%
Construction	0,9%	10,1	339 582	0,9%
Autre	8,1%	113,0	422 575	10,6%
Total	100,0%	1 070,0	325 567	100,0%

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

L'examen de la provenance des transferts, consigné dans le tableau 5, révèle que les flux internes dominant largement le paysage. En 2018, ils représentent 88,9% des transferts

en nombre et 77,0% du montant total, soit 819 milliards de FCFA. De plus, les transferts en provenance du reste du monde, bien que minoritaires en nombre (7,1% en 2018), se distinguent par un montant moyen nettement plus élevé, atteignant 841 310 FCFA, contre environ 279 000 FCFA pour les transferts internes. Cela reflète la capacité financière plus importante des migrants internationaux et leur rôle stratégique dans le soutien aux ménages bénéficiaires. Les transferts en provenance de la CEDEAO et des autres pays africains restent quant à eux très limités, représentant ensemble moins de 5% du montant total. Cependant, leurs montants moyens se distinguent avec 655 893 FCFA, valeur proche de celle du reste du monde, suggérant que les migrants établis sur le continent disposent également d'une capacité d'envoi non négligeable.

Table 5. Répartition des transferts monétaires selon l'origine en 2018

Origine du transfert	Part selon l'origine	Montant total (milliards FCFA)	Montant moyen (FCFA)	Part du montant
Interne	88,9%	819,0	279 145	77,0%
CEDEAO	2,9%	34,0	357 921	3,0%
Autre Afrique	1,2%	24,9	655 893	2,0%
RDM	7,1%	196,0	841 310	18,0%
Total	100,0%	1 070,0	325 499	100,0%

Note : RDM = Reste du Monde.

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

4.1.3 Privation multidimensionnelle des enfants

Privation des enfants non panel

Les enfants non panel désignent, dans notre analyse, les enfants que nous ne suivons pas en cohorte dans le temps. Dans ce cas particulier, nous suivons la situation des enfants ayant la même tranche d'âge dans le ménage entre les deux périodes en lieu et place d'un suivi individuel. Ainsi, l'analyse des indicateurs de privation multidimensionnelle de ces

enfants présentée dans le tableau 6 révèle des niveaux de privation élevés et persistants sur l'ensemble des dimensions considérées, à l'exception notable du travail des enfants qui reste largement faible. Le taux de privation lié à l'absence d'assurance atteint plus de 94,0% en 2018 et en 2021 pour l'ensemble des groupes. Ce qui traduit une quasi-absence de couverture sanitaire formelle parmi les ménages de l'échantillon. La dimension assainissement affiche également des taux de privation très élevés. Pour les enfants de 0–4 ans, ce taux atteint 69,5% en 2018 avant de reculer légèrement à 65,0% en 2021. Une tendance similaire s'observe pour les autres groupes d'âge. La dimension logement enregistre des taux de privation compris entre 51,9% et 68,3% selon les groupes d'âge en 2018. Entre 2018 et 2021, une amélioration est observée pour les enfants de 0–4 ans (de 68,3% à 63,6%) et de 5–14 ans (de 56,0% à 55,8%) tandis que ceux de 15–17 ans semblent légèrement moins touchés et enregistrent également des améliorations (de 51,9% à 44,0%). Les taux de privations relatives à l'accès à l'eau sont plus élevés pour les enfants de 5–14 ans (71,9% en 2018 et 37,9% en 2021) et de 15–17 ans (73,7% en 2018 et 78,8% en 2021). De plus, les enfants de 5–14 ans présentent un taux de non-fréquentation scolaire de 24,2% en 2018 qui progresse à 27,4% en 2021. Pour les 15–17 ans ce taux passe de 25,1% en 2018/2019 à 17,2% en 2021/2022.

Enfin, les statistiques sur le score du MODA global révèlent une augmentation des privations au seuil de trois et au seuil de quatre pour les enfants de 0–4 ans et de 15–17 ans avec des taux compris entre 49,5% et 82,6%. Pour la cible 5–14 ans en revanche, une amélioration du score MODA global est observée à ces mêmes seuils. Cette tendance s'inverse lorsqu'on considère les seuils de cinq et six, avec une augmentation chez les 5–14 ans et une amélioration chez les 0–4 ans et les 15–17 ans.

Table 6. Indicateurs de privation multidimensionnelle des enfants non panel par groupe d'âge

Dimensions	Indicateurs de privation	0–4 ans				5–14 ans				15–17 ans			
		2018		2021		2018		2021		2018		2021	
		Ind.	Dim.	Ind.	Dim.	Ind.	Dim.	Ind.	Dim.	Ind.	Dim.	Ind.	Dim.
Assainissement	Type de toilettes	42,1	69,5	39,3	65,9	37,2	61,9	38,6	65,0	31,7	59,2	29,6	57,3
	Partage des toilettes	38,1		37,6		33,8		35,5		36,6		35,7	
Eau	Source d'eau	29,4	44,5	24,8	71,9	23,6	73,7	28,1	42,7	24,6	37,9	19,7	78,8
	Temps d'accès à l'eau potable	28,2		59,2		62,0		27,1		25,2		69,9	
Logement	Surpeuplement du logement	36,3	68,3	28,2	56,0	24,6	51,9	34,4	63,6	32,1	55,8	25,2	44,0
	Toits, murs et sols	26,8		20,1		19,0		23,1		16,6		13,6	
	Disponibilité électricité	43,5		30,7		28,7		38,8		30,6		19,5	
Santé	Assurance	92,9	95,3	94,5	96,5	94,5	96,7	94,1	96,7	95,5	97,8	94,8	97,7
	MILDA	21,3		22,0		24,5		28,1		36,6		33,1	
Nutrition	Nourriture saine	48,7	63,0	50,5	62,7	—	—	—	—	—	—	—	—
	Nourriture variée	53,8		55,2		—		—		—		—	
	Nourriture à manger	23,5		25,6		—		—		—		—	
	Avoir faim	19,4		21,4		—		—		—		—	
	Nourriture en journée	8,7		9,5		—		—		—		—	
Protection contre le travail	Activité économique	—	—	—	—	1,0	1,4	2,0	2,1	—	—	—	—
	Heures travaillées	—		—		0,4		0,1		—		—	
Éducation	Fréquentation scolaire	—	—	—	—	24,2	30,6	25,1	31,8	27,4	57,5	17,2	48,6
	Réussite scolaire	—		—		20,2		20,0		57,5		48,6	
Information	Internet	—	—	—	—	—	—	—	—	76,3	41,6	78,2	37,2
	Télévision	—		—		—		—		48,2		43,4	
	Ordinateur	—		—		—		—		93,8		94,1	
MODA Global	MODA ≥ 3	76,9		82,6		72,2		66,3		69,7		78,4	
	MODA ≥ 4	53,6		54,0		38,6		38,2		49,5		53,8	
	MODA ≥ 5	20,5		18,9		9,5		12,1		31,5		26,7	
	MODA ≥ 6	—		—		0,3		0,6		11,7		7,0	

Note : « Ind. » = taux de privation de l'indicateur (%); « Dim. » = taux de privation de la dimension (%). “—” indique que l'indicateur n'est pas applicable pour le groupe d'âge concerné. MILDA = Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'Action.

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

Privation des enfants panel

Les enfants panel dans ce cas de figure désignent les enfants suivis individuellement dans le temps. Il s'agit de la même cohorte dont le suivi nous permet de faire des analyses de robustesse afin de vérifier si les résultats resteraient les mêmes lorsqu'il s'agit d'un

suivi panel. Ainsi l'analyse des enfants suivis en panel entre 2018 et 2021 est présentée dans le tableau [A.1](#) de l'annexe et les résultats confirment une aggravation générale de la privation multidimensionnelle sur la période. Le taux de MODA au seuil de trois, passe de 59,8% à 71,5% et au seuil de cinq de 25,5% à 38,1%. Ce qui indique que non seulement davantage d'enfants sont touchés mais qu'ils sont dans un plus grand nombre de dimensions simultanément. Les dimensions logement, assainissement et information enregistrent une baisse du niveau de privation entre les deux périodes. La dimension santé, comme dans le cas des cibles non panels, reste très élevée bien qu'elle connaisse une légère amélioration. En revanche, les dimensions eau, éducation et travail des enfants s'aggravent légèrement sur la période, le taux d'activité économique passant notamment de 2,3% à 3,0%.

4.2 Déterminants de la réception des transferts des migrants

Avant de procéder à l'estimation de l'effet causal des transferts migratoires sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, nous estimons un modèle logistique afin d'identifier les caractéristiques des ménages associées à la probabilité de recevoir des transferts. Cette étape est essentielle dans le cadre du PSM, car elle permet de déterminer les facteurs qui influencent la réception des transferts et, plus précisément, le score de propension étant donné les covariables observées. Ainsi, le modèle est estimé séparément pour chaque groupe d'âge cible par la méthode du maximum de vraisemblance avec des erreurs-types robustes, et les résultats complets sont présentés dans le tableau [A.2](#) de l'annexe et illustrés graphiquement dans la figure [1](#).

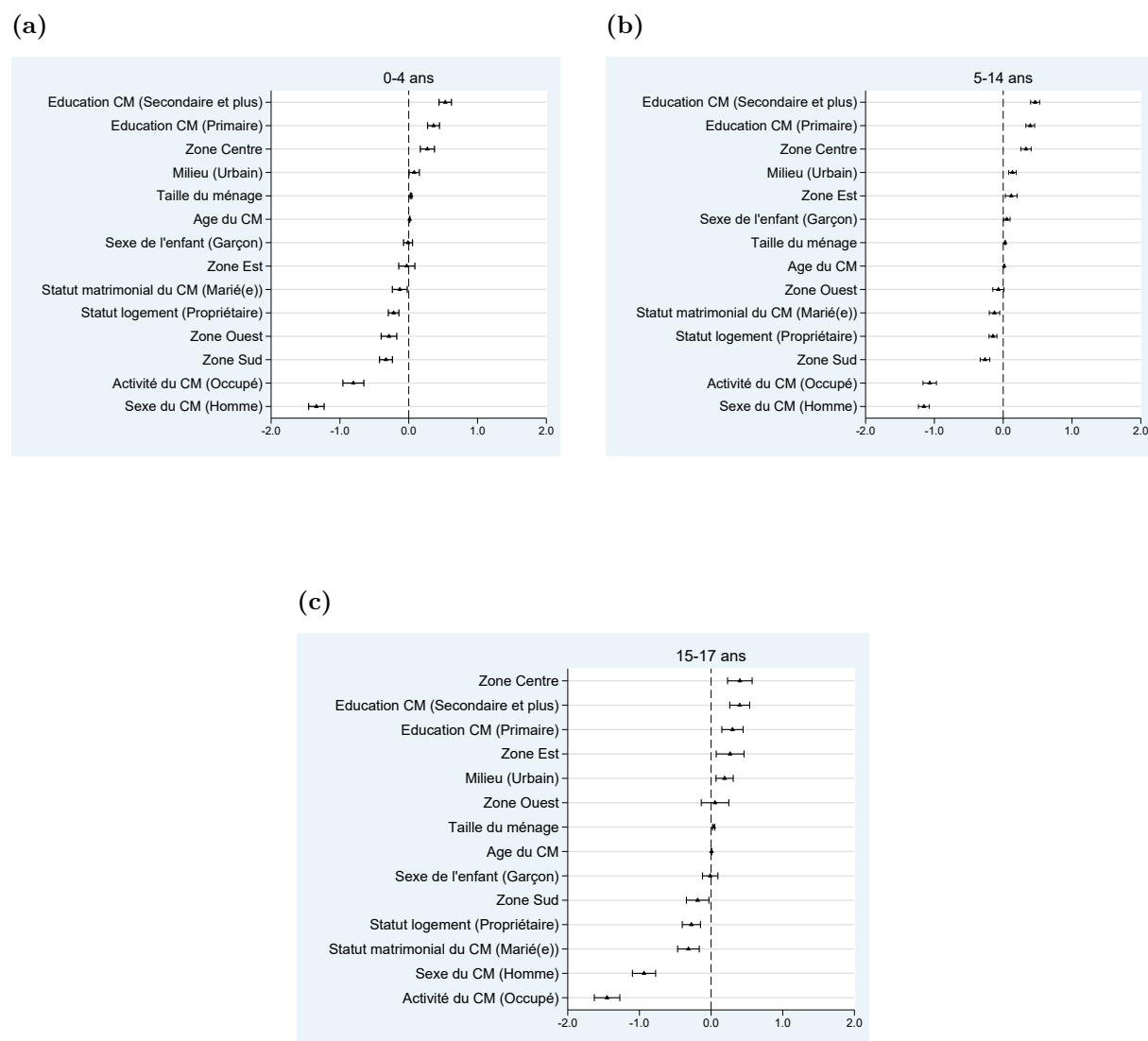
Il apparaît que le sexe du chef de ménage constitue le déterminant le plus puissant de la réception des transferts, et ce quel que soit le groupe d'âge considéré. Les ménages dirigés par un homme présentent une probabilité significativement plus faible de recevoir des transferts migratoires. Par rapport aux ménages à cheffe féminine, les ménages à

chef masculin ont respectivement 74%, 68% et 61% de chances en moins de recevoir des transferts pour les groupes 0–4 ans, 5–14 ans et 15–17 ans. De même, l'activité du chef de ménage exerce un effet négatif et significatif sur la réception des transferts. Un chef de ménage actif occupé réduit substantiellement la probabilité de recevoir des transferts, et l'effet s'amplifie avec l'âge des enfants. Les ménages avec un chef actif ont 55% de chances en moins de recevoir des transferts pour le groupe 0–4 ans, contre 66% pour le groupe 5–14 ans et 77% pour le groupe 15–17 ans. Toutefois, le niveau d'éducation du chef de ménage est positivement et significativement associé à la réception des transferts, quel que soit le groupe d'âge. Par rapport aux ménages dont le chef n'a aucun niveau d'instruction, les ménages avec un chef ayant un niveau primaire ont entre 35% et 43% de chances supplémentaires de recevoir des transferts selon le groupe d'âge, et ceux dont le chef a un niveau secondaire ou plus entre 49% et 70% de chances supplémentaires. De plus, la taille du ménage et l'âge du chef de ménage influencent positivement et significativement la réception des transferts dans tous les groupes d'âge. En revanche, le statut matrimonial et le statut de logement exercent des effets négatifs significatifs. Les ménages dont le chef est marié ont entre 12% et 27% de chances en moins de recevoir des transferts, et les propriétaires entre 16% et 24% de chances en moins selon le groupe d'âge. S'agissant des disparités géographiques, les ménages des zones Ouest et Sud reçoivent significativement moins de transferts que ceux de la zone Nord de référence, avec des probabilités inférieures allant respectivement jusqu'à 25% et 28% pour le groupe 0–4 ans, tandis que les ménages de la zone Centre en reçoivent davantage, avec une probabilité supérieure d'environ 31%. Enfin, le milieu urbain est positivement associé à la réception des transferts, toutes choses égales par ailleurs.

Ces résultats confirment la présence d'une sélection non aléatoire dans la réception des transferts migratoires, ce qui justifie le recours à la méthode d'appariement par le

score de propension (PSM) pour estimer l'effet causal des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants.

Figure 1. Estimation du modèle logistique de réception de transferts de migrants



Source : calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

4.3 Évaluation de la qualité de l'appariement

La fiabilité des estimations PSM dépend de la qualité de l'équilibre entre les groupes après appariement. Nous présentons dans les tableaux 7 à 9 et les figures 2 à 4 les diagnostics d'appariement pour chaque groupe d'âge, afin de s'assurer de la comparabilité des ménages traités et non traités avant d'interpréter les effets causaux.

Avant appariement, les tests de balancing révèlent des différences statistiquement

significatives entre les groupes traités et contrôles avec des p-values inférieures à 0,01 sur la quasi-totalité des variables observables et ceux pour tous les groupes d'âge. Ce qui confirme un déséquilibre initial important entre les deux groupes. Ce constat est cohérent avec les statistiques de qualité globale présentées dans le tableau 10, qui indiquent pour la cible 0–4 ans un Pseudo R^2 de 0,088 et un biais moyen de 17,8 avant appariement avec un Rubin's B de 71,5 largement supérieur au seuil de 25.

Après appariement, la situation s'améliore considérablement pour les deux méthodes dont le Kernel et les 5 plus proches voisins (5NN) mais de manière inégale. La méthode Kernel se révèle globalement plus performante en termes de réduction du biais statistique. Pour les enfants de 0–4 ans, le biais moyen après appariement atteint 1,3 avec le Kernel contre 1,6 avec le 5NN, et le Pseudo R^2 est de 0,001 dans les deux cas. La p-valeur du test du χ^2 global passe à 0,851 avec le Kernel, ce qui indique que les différences résiduelles ne sont plus statistiquement significatives, tandis qu'elle reste à 0,083 avec le 5NN qui traduit des différences encore légèrement perceptibles. Le Rubin's B demeure bien en dessous du seuil de 25 pour les deux méthodes, avec une valeur plus faible pour le Kernel. Des résultats similaires sont observés pour les groupes de 5–14 ans, 15–17 ans et pour les enfants panel qui constituent notre cohorte. Dans l'ensemble, la méthode Kernel produit donc un meilleur équilibre statistique, bien que les deux méthodes conduisent à des groupes comparables.

Sur le plan visuel, les figures 2 à 4 illustrent les distributions du score de propension après appariement pour les deux méthodes. Les courbes de densité des groupes traités et contrôles se superposent de manière satisfaisante dans les deux cas, avec toutefois une superposition visuellement plus nette pour la méthode 5NN, ce qui contraste légèrement avec les statistiques qui favorisent le Kernel. Cela s'explique par le fait que le 5NN tend à concentrer les observations appariées sur un support plus étroit. Ce qui donne

une impression visuelle de meilleure superposition alors que le Kernel lisse davantage la distribution sur l'ensemble du support commun. Pour la cible cohorte dont les résultats sont présentés dans le tableau A.3 et A.4 ainsi que la figure A.1, les tests restent toujours meilleurs avec le méthode Kernel.

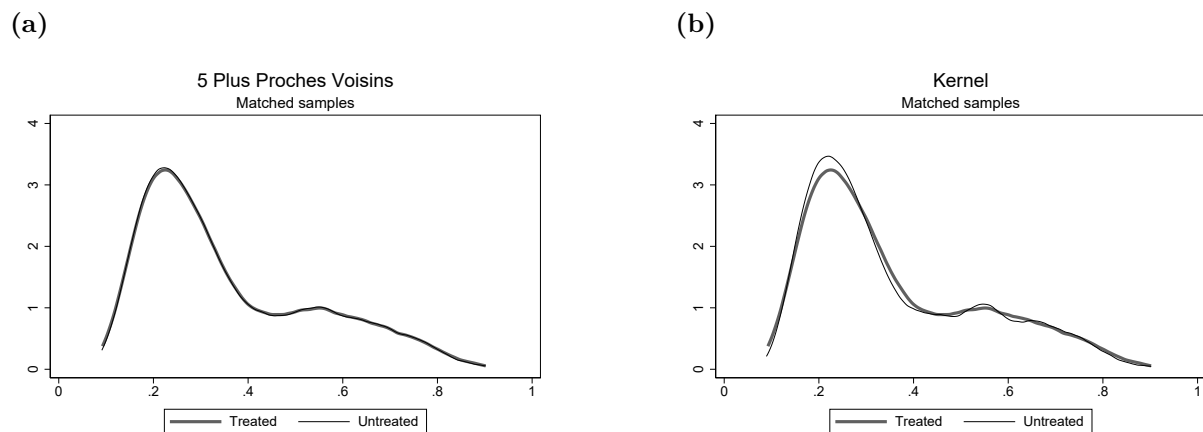
Table 7. Balancing test des échantillons appariés : Cible 0–4 ans

Variable	(1) Avant appariement			(2) Matching Kernel			(3) Matching 5 plus proches voisins		
	Traité	Contrôle	P-val.	Traité	Contrôle	P-val.	Traité	Contrôle	P-val.
Sexe de l'enfant (Garçon = 1)	0,504	0,510	0,430	0,504	0,510	0,532	0,504	0,511	0,463
Sexe du CM (Homme = 1)	0,734	0,928	0,000	0,735	0,739	0,641	0,735	0,735	0,976
Age du CM	43,26	40,52	0,000	43,24	43,37	0,615	43,24	43,24	1,000
Education du CM (Primaire)	0,206	0,183	0,000	0,206	0,206	0,931	0,206	0,195	0,172
Education du CM (Secondaire et plus)	0,221	0,165	0,000	0,221	0,219	0,792	0,221	0,231	0,209
Statut matrimonial du CM (Marié = 1)	0,747	0,880	0,000	0,748	0,741	0,425	0,748	0,737	0,207
Taille ménage	6,881	6,687	0,000	6,879	6,889	0,878	6,879	6,753	0,048
Occupation logement (Propriétaire = 1)	0,557	0,635	0,000	0,557	0,565	0,400	0,557	0,565	0,415
Activité du CM (Occupé = 1)	0,903	0,974	0,000	0,904	0,909	0,389	0,904	0,899	0,407
Zone Ouest	0,128	0,161	0,000	0,128	0,131	0,596	0,128	0,119	0,171
Zone Est	0,131	0,113	0,001	0,131	0,133	0,782	0,131	0,130	0,924
Zone Centre	0,225	0,136	0,000	0,225	0,213	0,125	0,225	0,215	0,239
Zone Sud	0,296	0,334	0,000	0,296	0,294	0,783	0,296	0,293	0,754
Milieu (Urbain = 1)	0,389	0,313	0,000	0,389	0,379	0,313	0,389	0,381	0,434
Année (2021 = 1)	0,405	0,506	0,000	0,406	0,417	0,209	0,406	0,410	0,646

*Note : CM = chef de ménage. Référence éducation : aucun niveau ; référence zone : zone Nord. P-valeurs en **gras** = différences significatives au seuil de 10 % ou moins. Échantillons limités au support commun.*

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

Figure 2. Densité du score de propension après appariement : Cible 0–4 ans



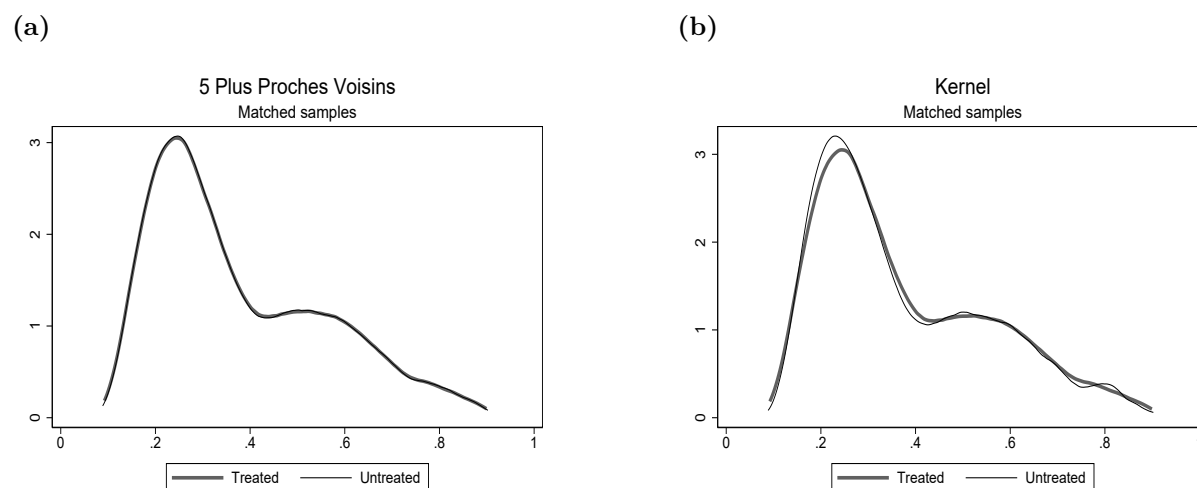
Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

Table 8. Balancing test des échantillons appariés : Cible 5–14 ans

Variable	(1) Avant appariement			(2) Matching Kernel			(3) Matching 5 plus proches voisins		
	Traité	Contrôle	P-val.	Traité	Contrôle	P-val.	Traité	Contrôle	P-val.
Sexe de l'enfant (Garçon = 1)	0,515	0,518	0,605	0,515	0,515	0,996	0,515	0,519	0,582
Sexe du CM (Homme = 1)	0,710	0,901	0,000	0,710	0,717	0,289	0,710	0,706	0,421
Age du CM	48,292	45,712	0,000	48,272	48,369	0,581	48,272	48,327	0,754
Education du CM (Primaire)	0,199	0,174	0,000	0,199	0,201	0,615	0,199	0,198	0,951
Education du CM (Secondaire et plus)	0,223	0,174	0,000	0,224	0,223	0,906	0,224	0,228	0,431
Statut matrimonial du CM (Marié = 1)	0,712	0,854	0,000	0,713	0,710	0,725	0,713	0,703	0,123
Taille ménage	7,263	7,275	0,729	7,263	7,255	0,861	7,263	7,030	0,000
Occupation logement (Propriétaire = 1)	0,611	0,683	0,000	0,611	0,619	0,245	0,611	0,604	0,316
Activité du CM (Occupé = 1)	0,869	0,967	0,000	0,870	0,876	0,182	0,870	0,876	0,184
Zone Ouest (réf. : Nord)	0,145	0,159	0,001	0,145	0,146	0,789	0,145	0,135	0,042
Zone Est	0,134	0,110	0,000	0,134	0,136	0,713	0,134	0,143	0,058
Zone Centre	0,240	0,153	0,000	0,239	0,235	0,477	0,239	0,233	0,284
Zone Sud	0,287	0,340	0,000	0,287	0,285	0,714	0,287	0,286	0,889
Milieu (Urbain = 1)	0,426	0,333	0,000	0,426	0,413	0,051	0,426	0,418	0,251
Année (2021 = 1)	0,457	0,564	0,000	0,457	0,461	0,536	0,457	0,450	0,283

*Note : CM = chef de ménage. Référence éducation : aucun niveau ; référence zone : zone Nord. P-valeurs en **gras** = différences significatives au seuil de 10 % ou moins. Échantillons limités au support commun.*

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

Figure 3. Densité du score de propension après appariement : Cible 5–14 ans

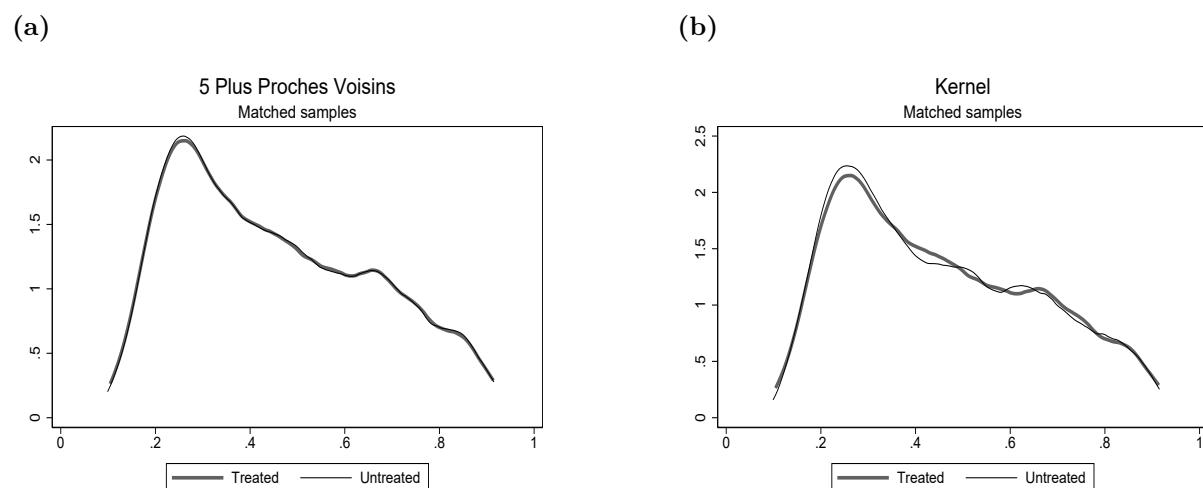
Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

Table 9. Balancing test des échantillons appariés : Cible 15–17 ans

Variable	(1) Avant appariement			(2) Matching Kernel			(3) Matching 5 plus proches voisins		
	Traité	Contrôle	P-val.	Traité	Contrôle	P-val.	Traité	Contrôle	P-val.
Sexe de l'enfant (Garçon = 1)	0,523	0,540	0,181	0,522	0,517	0,695	0,522	0,520	0,901
Sexe du CM (Homme = 1)	0,678	0,876	0,000	0,679	0,676	0,826	0,679	0,666	0,328
Age du CM	48,247	47,880	0,269	48,217	49,500	0,001	48,217	49,688	0,000
Education du CM (Primaire)	0,173	0,161	0,216	0,173	0,179	0,530	0,173	0,182	0,369
Education du CM (Secondaire et plus)	0,307	0,214	0,000	0,307	0,293	0,269	0,307	0,300	0,612
Statut matrimonial du CM (Marié = 1)	0,622	0,812	0,000	0,624	0,638	0,301	0,624	0,636	0,363
Taille ménage	7,253	7,393	0,119	7,252	7,272	0,850	7,252	7,128	0,236
Occupation logement (Propriétaire = 1)	0,523	0,641	0,000	0,524	0,549	0,073	0,524	0,552	0,048
Activité du CM (Occupé = 1)	0,782	0,949	0,000	0,783	0,789	0,651	0,783	0,788	0,691
Zone Ouest (réf. : Nord)	0,128	0,139	0,208	0,129	0,139	0,278	0,129	0,143	0,139
Zone Est	0,132	0,109	0,003	0,133	0,128	0,593	0,133	0,127	0,569
Zone Centre	0,246	0,162	0,000	0,244	0,243	0,944	0,244	0,249	0,715
Zone Sud	0,327	0,367	0,001	0,328	0,317	0,432	0,328	0,315	0,338
Milieu (Urbain = 1)	0,609	0,455	0,000	0,608	0,599	0,521	0,608	0,597	0,431
Année (2021 = 1)	0,446	0,552	0,000	0,447	0,455	0,547	0,447	0,449	0,879

Note : CM = chef de ménage. Référence éducation : aucun niveau ; référence zone : zone Nord. P-valeurs en **gras** = différences significatives au seuil de 10 % ou moins. Échantillons limités au support commun.

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

Figure 4. Densité du score de propension après appariement : Cible 15–17 ans

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

Table 10. Test de la qualité de l'appariement : bénéficiaires vs non-bénéficiaires – enfants non panel

Statistique	Cible 0–4 ans			Cible 5–14 ans			Cible 15–17 ans		
	Avant matching	Après matching (5NN)	Après matching (Kernel)	Avant matching	Après matching (5NN)	Après matching (Kernel)	Avant matching	Après matching (5NN)	Après matching (Kernel)
Pseudo R^2	0,088	0,001	0,001	0,089	0,002	0,000	0,114	0,004	0,002
$p > \chi^2$	0,000	0,083	0,851	0,000	0,000	0,807	0,000	0,016	0,411
Biais moyen	17,8	1,6	1,3	17,5	1,8	0,9	19,5	2,9	2,5
Rubin's B	71,5*	9,0	5,8	72,0*	9,3	4,3	82,1*	15,2	11,1

* Rubin's $B > 25$: déséquilibre résiduel significatif avant appariement.

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

4.4 Impact global des transferts des migrants sur la pauvreté multidimensionnelle

Les résultats des estimations de l'impact des transferts monétaires sur la privation multidimensionnelle des enfants non panel sont présentés dans le tableau 11. Il ressort que l'effet des transferts monétaires sur la privation multidimensionnelle des enfants varie sensiblement selon la méthode d'estimation utilisée et le groupe d'âge considéré. En particulier, les estimations issues de la méthode de DD suggèrent une augmentation significative de la privation totale pour les trois groupes d'âge. Ce résultat traduit vraisemblablement l'hétérogénéité initiale entre les groupes traités et contrôles avant appariement. En revanche, les estimations basées sur la méthode combinée PSM-DD considérée comme plus robuste indiquent globalement une réduction des privations, bien que ces effets soient souvent non significatifs.

Pour la cible 0–4 ans, les transferts réduisent significativement la privation en assainissement de 9,9% (PSM-DD ; $p < 0,01$), la privation en logement de 8,7% (PSM-DD ; $p < 0,01$). Ce qui indique une amélioration tangible des conditions d'hygiène et de l'habitat pour les plus jeunes enfants. En revanche, la dimension eau et le MODA au seuil de cinq

présentent une aggravation de la privation multidimensionnelle des enfants.

Pour la cible 5–14 ans, des effets similaires sont observés pour la privation en assainissement (PSM-DD ; $p < 0,05$) et en eau (PSM-DD ; $p < 0,05$). En revanche, le MODA au seuil de trois indique une amélioration de 3,0% (PSM-DD ; $p < 0,05$) des conditions et les autres indicateurs, même s'ils sont négatifs, demeurent non significatifs. Alors qu'on constate une amélioration du logement pour la cible 0–4 ans, ceux de 15–17 ans enregistrent une détérioration de cette dimension de 23,5% (PSM-DD ; $p < 0,01$). En revanche les transferts améliorent la privation en éducation de 16,6% (PSM-DD ; $p < 0,01$) pour cette dernière. De plus des résultats opposés sont observés entre le MODA au seuil de trois ($-0,146$; $p < 0,01$) et au seuil de cinq ($0,121$; $p < 0,05$), les autres indicateurs détectent des effets non significatifs.

Pour tester la robustesse des résultats, nous avons constitué une cohorte d'enfants suivis dans le temps afin de déterminer l'impact des transferts lorsque nous suivons les mêmes enfants. Les résultats PSM-DD présentés dans le tableau [A.5](#) en annexes indiquent une réduction significative de la privation totale ($-0,151$; $p < 0,05$), le logement ($-0,078$; $p < 0,05$), l'assainissement ($-0,050$; $p < 0,10$) et le MODA ≥ 3 ($-0,066$; $p < 0,05$). La convergence de ces résultats avec ceux obtenus pour les enfants non panel, notamment sur les dimensions logement et assainissement, renforce la validité interne des estimations et confirme que les transferts monétaires contribuent effectivement à réduire la privation multidimensionnelle des enfants.

Table 11. Impact des transferts sur les indicateurs de privation : enfants non panel

Indicateurs	Cible 0–4 ans			Cible 5–14 ans			Cible 15–17 ans		
	PSM	DD	PSM-DD	PSM	DD	PSM-DD	PSM	DD	PSM-DD
Privation totale	–0,014 (0,014)	0,147*** (0,029)	–0,052 (0,056)	0,007 (0,012)	0,099*** (0,024)	–0,045 (0,039)	–0,036 (0,034)	0,220*** (0,060)	–0,143 (0,226)
Assainissement	0,001 (0,006)	0,031** (0,013)	–0,099*** (0,024)	0,011** (0,005)	0,003 (0,010)	–0,037** (0,016)	0,017 (0,012)	0,007 (0,022)	0,023 (0,078)
Santé	–0,000 (0,003)	–0,012** (0,006)	–0,015 (0,011)	0,002 (0,002)	–0,007** (0,004)	–0,004 (0,005)	–0,008** (0,003)	–0,002 (0,007)	0,018 (0,023)
Eau	–0,010 (0,007)	0,123*** (0,015)	0,056** (0,026)	–0,003 (0,005)	0,095*** (0,011)	0,040** (0,016)	–0,014 (0,012)	0,094*** (0,023)	–0,061 (0,076)
Logement	–0,003 (0,007)	0,005 (0,014)	–0,087*** (0,026)	–0,001 (0,005)	0,005 (0,010)	–0,022 (0,016)	0,005 (0,012)	0,025 (0,023)	0,235*** (0,060)
Nutrition	–0,002 (0,003)	–0,000 (0,008)	0,009 (0,013)	—	—	—	—	—	—
Education	—	—	—	–0,004 (0,005)	0,001 (0,011)	–0,004 (0,015)	–0,026 (0,012)	0,040* (0,023)	–0,166*** (0,064)
Travail	—	—	—	0,003** (0,001)	0,002 (0,003)	–0,000 (0,005)	—	—	—
Information	—	—	—	—	—	—	0,005 (0,012)	0,056** (0,022)	0,067 (0,060)
MODA ≥ 3	–0,002 (0,006)	0,051*** (0,014)	–0,039 (0,025)	0,006 (0,005)	0,021** (0,009)	–0,030** (0,015)	–0,008 (0,010)	0,027 (0,018)	–0,146*** (0,053)
MODA ≥ 4	–0,002 (0,007)	0,068*** (0,015)	–0,012 (0,025)	0,001 (0,005)	0,032*** (0,011)	–0,011 (0,017)	0,010 (0,012)	0,057** (0,022)	–0,094 (0,062)
MODA ≥ 5	–0,002 (0,002)	0,002 (0,005)	0,014* (0,008)	–0,001 (0,004)	0,025*** (0,007)	0,004 (0,011)	–0,010 (0,012)	0,050** (0,022)	0,121** (0,056)
MODA ≥ 6	—	—	—	0,001 (0,001)	0,002 (0,002)	0,002 (0,002)	–0,015 (0,008)	0,066*** (0,015)	–0,000 (0,042)

*Note : Erreurs standard entre parenthèses. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. PSM = Propensity Score Matching; DD = Différence en Différences; PSM-DD = combinaison des deux méthodes. “—” : indicateur non applicable pour le groupe d’âge concerné.*

Source : Calculs de l’auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

4.5 Mesure de l’impact des transferts selon leur niveau d’intensité

Pour appréhender l’intensité de l’impact des transferts monétaires sur la privation multidimensionnelle des enfants, nous distinguons trois niveaux selon le montant reçu. L’intensité 1 correspond aux transferts inférieurs au Salaire minimum interprofessionnel

garanti (SMIG) évalué à 60 000 FCFA en 2018. L'intensité 2 correspond aux transferts compris entre 60 000 et 120 000 FCFA, et l'intensité 3 est relative aux transferts supérieurs à 120 000 FCFA. Le tableau [A.6](#) en annexes présente les résultats de l'effet moyen du traitement sur les traités pour chaque niveau d'intensité. Il ressort que les spécifications produisent des résultats globalement cohérents pour les intensités 1 et 2, tandis que les estimations divergent davantage pour l'intensité 3. De manière générale, plus le montant des transferts est modéré, plus l'impact sur la réduction de la privation multidimensionnelle est significatif et cohérent entre les spécifications. Ces résultats décèlent l'existence d'un effet non linéaire des transferts, les montants intermédiaires étant les plus efficaces.

5 Discussions

Les résultats obtenus mettent en évidence un effet globalement hétérogène des transferts monétaires des migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants tant selon les dimensions du bien-être que selon le groupe d'âge. Cette hétérogénéité souligne que les transferts n'agissent pas de manière uniforme, mais dépendent des besoins spécifiques des ménages et des arbitrages intra-familiaux. De même, l'analyse de l'impact selon l'intensité des montants reçus révèle des effets contrastés selon le montant et la dimension considérés.

Les résultats relatifs à la privation totale révèlent un effet négatif des transferts, mais celui-ci demeure statistiquement non significatif pour les enfants suivis au niveau ménage. En revanche, lorsque l'on suit les mêmes enfants dans le temps à travers l'analyse en panel, les estimations PSM-DD indiquent une réduction significative de la privation multidimensionnelle totale. Cela implique que l'effet des transferts sur la pauvreté multidimensionnelle globale n'est pas immédiatement perceptible lorsque l'on compare des enfants d'âges similaires entre deux périodes mais le devient si l'on contrôle pour l'hétérogénéité individuelle inobservable propre à chaque enfant en suivant les mêmes cohortes. Autrement dit, les

transferts produisent un effet cumulatif sur le bien-être des enfants qui ne se manifeste pleinement qu'à travers un suivi longitudinal. Ce résultat est cohérent avec les conclusions de Yang (2011) qui souligne que les effets des transferts sur les conditions de vie des ménages ne se matérialisent pleinement qu'au fil du temps, à mesure que les ménages ajustent leurs comportements de dépense et d'investissement.

De même, un effet réducteur et significatif des transferts sur la privation en assainissement est observé pour les enfants de 0–14 ans. Ce résultat est cohérent avec les travaux de Nguyen et al. (2025) qui montrent que les transferts augmentent significativement la probabilité pour les ménages ruraux de disposer de toilettes améliorées en Thaïlande et au Vietnam. En Côte d'Ivoire, en 2018 où le taux de privation en assainissement dépasse 65% pour les jeunes enfants, l'injection de ressources financières extérieures permet aux ménages de lever les contraintes de liquidité et d'investir dans des infrastructures sanitaires de base (Tsafack et Djeunankan, 2021), notamment dans les zones péri-urbaines et rurales où la plupart des ménages vivent dans des cours communes avec des toilettes publiques. Ce résultat est d'autant plus important que l'amélioration des conditions d'assainissement pour les enfants en bas âge, constitue un déterminant majeur de leur survie et de leur développement cognitif à long terme. Par ailleurs, les résultats obtenus sur les enfants suivis en cohorte confirment ces conclusions, ce qui confirme la robustesse des estimations.

Les transferts permettent également de réduire la privation en éducation pour les 15–17 ans, sans effet significatif pour les autres groupes d'âge. Ce résultat est cohérent avec les travaux de Feldmann (2025) qui confirment l'effet positif des transferts sur les taux d'inscription au primaire et au secondaire dans les pays en développement. En effet, Feldmann (2025) souligne que les transferts contribuent à lever les contraintes de liquidité et à financer les coûts directs et indirects de l'éducation avec un effet plus marqué pour les niveaux d'enseignement supérieur où les coûts sont plus élevés. Toutefois, lorsque l'on suit

les mêmes individus dans le temps, les résultats demeurent non significatifs. Ce constat rejoint les conclusions de Tello et Sánchez (2025) qui montrent que les transferts, bien qu'ils augmentent les dépenses scolaires, n'ont pas d'effet significatif sur les années de scolarité ni sur le retard scolaire. Cela implique un effet plus marqué sur les dépenses éducatives que sur les résultats scolaires.

L'impact positif des transferts sur la privation en eau peut s'avérer contre-intuitif, d'autant plus que des travaux empiriques (Tsafack et Djeunankan, 2021) montrent que les transferts permettent aux ménages de financer leurs propres solutions d'approvisionnement à savoir la construction de puits améliorés ou de forages. Toutefois, ce résultat peut s'expliquer par les contraintes structurelles qui caractérisent le secteur de l'eau en Côte d'Ivoire (Ministère du Plan et du Développement et UNICEF, 2018). Malgré ces investissements privés potentiels, l'accès à l'eau potable reste limité par insuffisance d'infrastructure de production et de distribution, en particulier dans les zones rurales et péri-urbaines. De nombreuses localités ne sont pas raccordées aux réseaux, tandis que certaines sources d'eau sont dégradées ou surexploitées (Ministère du Plan et du Développement et UNICEF, 2018). Dans ce contexte, même lorsque les ménages disposent de ressources supplémentaires grâce aux transferts, leur capacité à améliorer effectivement leur accès à l'eau potable demeure contrainte par l'environnement institutionnel et infra-structurel. Les transferts peuvent ne pas se traduire par une réduction de la privation, voire engendrer des effets ambigus.

Les résultats sur les indices MODA confirment et synthétisent les effets sectoriels observés. Pour les enfants de 5–17 ans, le MODA au seuil de trois est réduit de manière significative. Ce qui indique que les transferts permettent de sortir certains enfants d'une situation de privation simultanée dans au moins trois dimensions, résultats cohérents avec ceux obtenus pour les enfants. En revanche, des résultats contrastés sont observés pour les

enfants de 15–17 ans pour le MODA au seuil de cinq, ce qui indique que les transferts réduisent les privations modérées mais pas les situations de privations les plus profondes. Ces résultats sont cohérents avec le cadre théorique d’Alkire et Foster (2011) qui distingue l’incidence de la pauvreté multidimensionnelle de sa profondeur. En Côte d’Ivoire, les transferts semblent davantage agir sur le nombre d’enfants touchés par des privations multiples inférieures que sur ceux touchés en profondeur. Ce constat rejoint également les conclusions de Bayangos et Lubangco (2025), qui soulignent que les transferts ont tendance à répondre à des besoins immédiats plutôt qu’à financer des investissements transformateurs à long terme.

Afin d’approfondir l’analyse, nous distinguons trois niveaux d’intensité selon le montant des transferts reçus. Les résultats révèlent que l’effet des transferts sur la réduction de la privation multidimensionnelle n’est pas uniforme. Les transferts de faible montant et de montant intermédiaire indiquent une réduction significative de la privation totale ainsi que de certaines dimensions spécifiques, notamment le logement et les indices de privation multidimensionnelle. En revanche, pour les montants élevés, un résultat particulier est observé. La privation liée au travail des enfants augmente de manière significative avec le montant. Ce qui indique que les transferts élevés sont associés à une aggravation du travail des enfants. Ce résultat contre-intuitif peut s’expliquer par le fait que les ménages qui reçoivent des montants élevés utilisent ces ressources pour développer des activités économiques, formelles ou informelles dans lesquelles les adolescents sont mobilisés comme main-d’œuvre familiale, notamment dans le secteur agricole très répandu en Côte d’Ivoire (Gouvernement de Côte d’Ivoire, 2019). Le recours au travail des enfants n’est pas uniquement déterminé par la contrainte financière mais également par des facteurs structurels tels que la demande de main-d’œuvre et les normes culturelles. En effet, dans le contexte ivoirien, l’arbitrage entre la scolarisation et le travail résulte souvent d’une logique

où le rendement immédiat du travail de l'enfant est perçu comme supérieur au rendement attendu de l'éducation, en particulier dans les ménages dont le chef n'a lui-même pas été scolarisé (Abou, 2019). Ces constats rejoignent les observations de Feldmann (2025) qui souligne que la réduction du travail infantile constitue un canal d'effet des transferts difficile à activer en l'absence de politiques d'accompagnement spécifiques.

Bien que cette étude offre une analyse approfondie du rôle des transferts des migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants, certaines limites doivent être reconnues. D'abord, plusieurs dimensions du cadre MODA telles que proposées par l'UNICEF ont nécessité des adaptations en raison des contraintes liées aux variables disponibles dans l'EHCVM (de Neubourg et al., 2012). En particulier, la dimension de la nutrition repose sur des proxys issus de l'échelle FIES, en l'absence de mesures anthropométriques directes, tandis que la dimension information est appréhendée uniquement à travers la disponibilité d'équipements au sein du ménage. Ces approximations peuvent affecter la précision de la mesure des privations correspondantes (Alkire et Foster, 2011). Par ailleurs, certaines dimensions du bien-être des enfants n'ont pu être intégrées faute de données disponibles, ce qui restreint la portée de l'analyse multidimensionnelle. Ensuite, l'approche par union adoptée pour l'identification des enfants pauvres reste sujette à des critiques dans la littérature. Alkire et Foster (2011) soulignent qu'elle tend à surestimer la pauvreté par l'inclusion des individus qui présentent une privation isolée qui peut relever d'une erreur de mesure plutôt que d'une situation de pauvreté avérée, et qu'elle perd en pouvoir discriminant lorsque le nombre de dimensions considérées est élevé. En outre, la construction du panel à partir des deux vagues de l'EHCVM (2018/2019 et 2021/2022) a entraîné une attrition d'environ 40 % des ménages. Dans la mesure où cette attrition peut ne pas être aléatoire, elle est susceptible d'introduire un biais de sélection si les ménages sortants présentent des caractéristiques systématiquement différentes de ceux retenus dans l'échantillon final.

De plus, la mise en œuvre du PSM implique une restriction de l'échantillon au support commun, ce qui conduit à l'exclusion des ménages traités dont le score de propension se situe en dehors de la zone de chevauchement avec les ménages non traités. Si cette condition est nécessaire pour garantir la comparabilité des groupes, elle restreint la portée des estimations à une sous-population spécifique de ménages bénéficiaires, à savoir ceux dont les caractéristiques observables sont suffisamment proches des non-bénéficiaires. L'effet estimé correspond donc à l'effet moyen du traitement sur les traités dans le support commun (ATT), et ne peut être généralisé à l'ensemble des ménages bénéficiaires, en particulier les plus atypiques (Caliendo et Kopeinig, 2008). Enfin, la validité de l'estimateur qui combine le score de propension et la double différence (PSM-DD) repose sur l'hypothèse de tendances parallèles entre les groupes traités et de contrôle. Si le PSM permet de réduire les différences initiales en rendant les groupes comparables sur les caractéristiques observables, il ne garantit pas la vérification de cette hypothèse (Smith et Todd, 1997). En l'absence de données sur des périodes antérieures aux deux vagues disponibles, cette hypothèse ne peut être testée directement, ce qui constitue une limite importante de la stratégie d'identification adoptée.

Ces limites invitent à interpréter les résultats avec prudence et ouvrent des perspectives de recherche future, notamment par le recours à des données longitudinales plus complètes et à des mesures directes des privations infantiles.

6 Conclusion et implications de politique publique

À notre connaissance, cette étude est l'une des premières à mobiliser l'approche MODA pour mesurer l'impact des transferts des migrants sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants en Côte d'Ivoire. À partir d'une approche basée sur le score de propension combinée à la double différence, les estimations indiquent des effets significatifs mais

différenciés selon les groupes d'âge et les dimensions du bien-être. Les transferts améliorent principalement les conditions d'hygiène et d'habitat pour les plus jeunes, et favorisent le maintien scolaire pour les adolescents. De plus, une réduction significative de l'indice de privation multidimensionnelle globale est observée au seuil le plus inclusif. Toutefois, à des seuils plus élevés, les tendances s'inversent et les effets deviennent non significatifs, voire indiquent une aggravation des privations. Ces résultats sont corroborés par l'analyse en panel, qui renforce leur validité interne. Par ailleurs, l'analyse par intensité révèle un effet non linéaire des transferts. Les montants intermédiaires produisent les effets les plus robustes, tandis que les transferts élevés génèrent des résultats moins stables. En définitive, les transferts des migrants constituent un levier réel, quoique partiel, de réduction de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Leur impact se concentre sur les dimensions directement liées aux dépenses courantes du ménage, et demeure limité sur les dimensions structurelles telles que la santé, dont l'amélioration requiert des interventions publiques de plus grande portée. Les résultats de cette analyse offrent plusieurs enseignements pour les politiques publiques de lutte contre la pauvreté infantile. Compte tenu de leur rôle avéré dans la réduction de la pauvreté infantile, les coûts de transaction liés aux transferts de fonds des migrants devraient être réduits, notamment par le développement des corridors de transfert formels et des services de mobile money. Cependant, l'effet contraire observé aux seuils élevés de privation suggère que les transferts inter-ménages ne doivent pas être la seule réponse pour les enfants les plus démunis. Par ailleurs, la dimension santé demeure la plus cruciale et la plus résistante à l'effet des transferts, ce qui plaide en faveur d'une extension prioritaire de la Couverture Maladie Universelle à tous les ménages, ce déficit structurel ne pouvant être comblé par les seules ressources privées. De plus, l'aggravation du travail des enfants observée pour les transferts élevés appelle au renforcement des mécanismes de protection contre le travail infantile, notamment par des

programmes de sensibilisation sur les rendements à long terme de la scolarisation et par un encadrement des activités économiques dans lesquelles les adolescents sont mobilisés. Enfin, l'hétérogénéité des effets selon les dimensions du bien-être appelle à articuler les transferts à des programmes de protection sociale ciblés, notamment en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, afin de démultiplier leur impact sur les conditions de vie des enfants.

Références

- Abdulai, A.-M., & Boakye-Yiadom, L., & Quartey, P. (2017). The Impact of Migration on the Welfare of Households in Ghana : A Propensity Score Matching Approach. *African Human Mobility Review*, 3(1). <https://doi.org/10.14426/ahmr.v3i1.919>
- Abou, P. E. (2019). A Re-Examination of the Determinants of Child Labour in Côte d'Ivoire. *International Journal of Economics and Financial Research*, 5(2), 26-35.
- Adams, R., & Page, J. (2005). Do international migration and remittance reduce poverty in developing countries? *World Development*, 33, 1645-1669. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.05.004>
- Ahmed, F., & Dzator, J., & Acheampong, A. O. (2023). Do remittances reduce school dropout in Bangladesh ? The role of government's administrative and structural support. *Journal of Policy Modeling*, 45(2), 388-404. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2023.04.002>
- Ajefu, J. B., & Ogebe, J. O. (2021). The effects of international remittances on expenditure patterns of the left-behind households in Sub-Saharan Africa. *Review of Development Economics*, 25(1), 405-429. <https://doi.org/10.1111/rode.12721>

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7), 476-487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Antman, F. (2012). The Impact of Migration on Family Left Behind. *International Handbook on the Economics of Migration*. <https://doi.org/10.4337/9781782546078.00025>
- Babatunde, R. O. (2018). Impact of Remittances on Food Security and Nutrition of Migrants Household : Evidence from Nigeria. *AgEcon Search*. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.276986>
- Bayangos, V. B., & Lubangco, C. K. (2025). Do remittances boost household spending : New evidence from migrants' household survey. *Latin American Journal of Central Banking*, 100196. <https://doi.org/10.1016/j.latchb.2025.100196>
- Caliendo, M., & Kopeinig, S. (2008). Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity Score Matching. *Journal of Economic Surveys*, 22(1), 31-72. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00527.x>
- Chabé-Ferret, S. (2015). Analysis of the bias of Matching and Difference-in-Difference under alternative earnings and selection processes. *Journal of Econometrics*, 185(1), 110-123. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2014.09.013>
- Chakravarty, S. . (1990). *Ethical social index numbers*. Springer-Verlag.
- De Haas, H. (2010). Migration and Development : A Theoretical Perspective. *International Migration Review*, 44(1), 227-264. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2009.00804.x>
- de Neubourg, C., & Chai, J., & de Milliano, M., & Plavgo, I., & Wei, Z. (2012). *Step-by-Step Guidelines to the Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA)*

- ([**working paper**] N° 2012-10). UNICEF Office of Research. Florence. Consulté le 12 février 2026 à <https://www.unicef-irc.org/publications/695>
- Feldmann, H. (2025). The effects of remittances on school enrollment rates : A global perspective. *International Review of Economics & Finance*, 101, 104175. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104175>
- Gosselin-Pali, A. (2025). Migration and nutrition of the left behind : Evidence from Ghana. *World Development*, 188, 106853. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106853>
- Gouvernement de Côte d'Ivoire. (2019). *Plan d'Action National contre le travail des enfants 2019-2021* ([rapp. tech.]). Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale. Abidjan.
- Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, Unemployment and Development : A Two-Sector Analysis. *The American Economic Review*, 60(1), 126-142. <https://www.jstor.org/stable/1807860>
- Hasibuan, I. P. S., & Hartono, D. (2024). Remittances and multidimensional energy poverty of households in Indonesia. *Economic Analysis and Policy*, 83, 29-41. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2024.05.022>
- Institut National de la Statistique (INS). (2018). Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM 2018).
- Islam, M. M., & Khan, M. N., & Mondal, M. N. I. (2019). Does parental migration have any impact on nutritional disorders among left-behind children in Bangladesh ? *Public Health Nutrition*, 22(1), 95-103. <https://doi.org/10.1017/S1368980018002963>
- Jayaweera, R., & Verma, R. (2023). Are remittances a solution to housing issues ? A case study from Sri Lanka. *Social Sciences & Humanities Open*, 7(1), 100392. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100392>

- Lecocq. (2014, septembre). Résumés méthodologiques : Évaluation d'impact n° 8, Conception quasi-expérimentale et méthodes - Monde | ReliefWeb. Consulté le 3 avril 2026 à <https://reliefweb.int/report/world/methodological-briefs-impact-evaluation-no-8-quasi-experimental-design-and-methods>
- Lindner, S., & McConnell, K. J. (2019). Difference-in-differences and matching on outcomes : a tale of two unobservables. *Health Services and Outcomes Research Methodology*, 19(2–3), 127-144. <https://doi.org/10.1007/s10742-018-0189-0>
- Mathebula, J., & Alaba, O. (2024). Under-Five Child Poverty and Income Inequality in South Africa : A Multidimensional Perspective. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 22(1), 6. <https://doi.org/10.3390/ijerph22010006>
- Ministère du Plan et du Développement & UNICEF. (2018, novembre). *Analyse des privations multiples des enfants en Côte d'Ivoire selon le modèle N-MODA*. Office National de la Population. Abidjan.
- Nations Unies. (1989). Convention relative aux droits de l'enfant [Résolution 44/25 de l'Assemblée générale, 20 novembre 1989]. <https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- Nations Unies. (2015). Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030 [Résolution A/RES/70/1 de l'Assemblée générale, 25 septembre 2015].
- Neubourg, C. d. (2014). Lost (in) Dimensions : Consolidating progress in multidimensional poverty research. *UNICEF Office of Research Working Paper*. https://www.academia.edu/120393093/Lost_in_Dimensions_Consolidating_progress_in_multidimensional_poverty_research

- Nguyen, T. T., & Nguyen, T.-T., & Do, M. H., & Rahut, D., & Nguyen, D. L. (2025). Remittances, sanitation and child malnutrition in middle-income countries : A case study from rural Northeast Thailand and Central Vietnam. *World Development*, 190, 106975. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.106975>
- Nussbaum, M. C., & Sen, A. (1993, mars). *The Quality of Life*. Oxford University Press.
- Organisation Internationale pour les Migrations. (2021). World Migration Report 2022.
- Piguet, E. (2010). La volonté de migrer. Etat des lieux théorique. *Revue européenne des migrations internationales*. <https://libra.unine.ch/handle/20.500.14713/34580>
- Pradhan, I., & Pradhan, J., & Kandapan, B. (2023). Assessing reduction in multidimensional childhood poverty in India : a decomposition analysis. *BMC Public Health*, 23, 2024. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16869-0>
- Qiu, H., & Liang, X., & Sun, D. (2024). Parental migration, sibling migration, and the educational outcomes of children left behind in rural China. *Children and Youth Services Review*, 157, 107392. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107392>
- Ramkissoon, B., & Deonanan, R. (2023). How do remittances impact child mortality and are there preconditions ? *Social Science & Medicine*, 333, 116178. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116178>
- Ratha, D., & Chandra, V., & Kim, E. J., & Mahmood, A., & Plaza, S. (2024, juin). *Migration and Development Brief 40 : Remittances Slowed in 2023, Expected to Grow Faster in 2024* ([**migration and development brief**] N° 40). World Bank. Washington, D.C. <https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-40>
- Ravallion, M. (1992). *Poverty comparisons : a guide to concepts and methods*. The World Bank.

- Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1), 41-55.
- Ryan, A. M., & Burgess, J. F., & Dimick, J. B. (2015). Why We Should Not Be Indifferent to Specification Choices for Difference-in-Differences. *Health Services Research*, 50(4), 1211-1235. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.12270>
- Sen, A. (1987). *Commodities and Capabilities*. Teri Publication. <http://archive.org/details/dli.ernet.474268>
- Shadish, W. R., & Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton, Mifflin ; Company.
- Smith, J. A., & Todd, P. E. (1997). Matching as an Econometric Evaluation Estimator : Evidence from Evaluating a Job Training Programme. *The Review of Economic Studies*, 64(4), 605-654. <https://doi.org/10.2307/2971733>
- Smith, J. A., & Todd, P. E. (2005). Does matching overcome LaLonde's critique of nonexperimental estimators? *Journal of Econometrics*, 125(1), 305-353. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2004.04.011>
- Stark, O. (1993). *The migration of labor* (1. publ. in paperback). Blackwell.
- Stark, O., & Bloom, D. E. (1985). The New Economics of Labor Migration. *The American Economic Review*, 75(2), 173-178. <https://www.jstor.org/stable/1805591>
- Sulemana, I., & Bugri Anarfo, E., & Doabil, L. (2023). Migrant Remittances and Food Security in Sub-Saharan Africa : The Role of Income Classifications. *International Migration Review*, 57(2), 681-706. <https://doi.org/10.1177/01979183221107925>
- Tello, M., & Sánchez, G. E. (2025). Paternal migration and schooling choices. A study on children left behind in Ecuador. *International Journal of Educational Development*, 114, 103254. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2025.103254>

- Tsafack, R., & Djeunankan, R. (2021). Do remittances improve access to safe drinking water and sanitation in developing countries? *Economics Bulletin*, 41(4), 2697-2710.
<https://ideas.repec.org/a/ebl/ecbull/eb-21-00803.html>
- UNDP & OPHI. (2023). *2023 Global Multidimensional Poverty Index : Unstacking Global Poverty*. United Nations Development Programme, Oxford Poverty et Human Development Initiative. New York.
- UNESCO. (2018). A meta-analysis of the effects of remittances on household education expenditure. Consulté le 12 février 2026 à <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266074>
- White, H., & Sabarwal, S. (2014). Quasi-experimental design and methods. *Methodological briefs : impact evaluation*, 8(2014), 1-16.
- Yang, D. (2011). Migrant Remittances. *Journal of Economic Perspectives*, 25(3), 129-152.
<https://doi.org/10.1257/jep.25.3.129>

Annexes

Table A.1. Indicateurs de privation multidimensionnelle : Enfants Panel

Dimension	Indicateur	2018		2021	
		Ind.	Dim.	Ind.	Dim.
Assainissement	Type de toilettes	38,1	64,6	33,6	59,1
	Partage des toilettes	35,4		33,8	
Eau	Source d'eau	27,8	42,2	21,7	75,8
	Accès eau potable (temps)	26,7		65,5	
Logement	Surpeuplement	34,3	63,2	24,6	48,2
	Toits, murs et sols	22,5		16,5	
	Électricité	38,3		24,7	
Santé	Assurance	94,3	97,0	94,5	96,9
	MILDA	28,8		27,5	
Éducation	Fréquentation scolaire	20,0	27,6	16,0	32,5
	Réussite scolaire	22,7		32,5	
Information	Internet	97,5	51,8	92,0	43,5
	Télévision	52,5		45,5	
	Ordinateur	96,0		95,8	
Protection contre le travail	Activité économique	2,3	2,4	3,0	3,8
	Heures travaillées	0,1		0,9	
MODA Global	MODA ≥ 3	59,8		71,5	
	MODA ≥ 4	25,5		38,1	

Note : « Ind. » = taux de privation de l'indicateur (%); « Dim. » = taux de privation de la dimension (%). MILDA = Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d'Action.

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

Table A.2. Déterminants de la réception de transferts migratoires par groupe d'âge

	0–4 ans	5–14 ans	15–17 ans	Panel
Sexe de l'enfant (garçon)	–0,010 [–0,08 ; 0,05]	0,052** [0,00 ; 0,10]	–0,012 [–0,12 ; 0,09]	0,008 [–0,02 ; 0,03]
Sexe du CM (homme)	–1,342*** [–1,45 ; –1,23]	–1,152*** [–1,23 ; –1,07]	–0,936*** [–1,10 ; –0,77]	–1,069*** [–1,11 ; –1,03]
Âge du CM	0,014*** [0,01 ; 0,02]	0,015*** [0,01 ; 0,02]	0,006*** [0,00 ; 0,01]	0,014*** [0,01 ; 0,01]
Éducation CM : primaire	0,360*** [0,27 ; 0,45]	0,394*** [0,33 ; 0,46]	0,298*** [0,15 ; 0,45]	0,342*** [0,31 ; 0,38]
Éducation CM : secondaire et plus	0,531*** [0,44 ; 0,62]	0,464*** [0,40 ; 0,53]	0,399*** [0,26 ; 0,54]	0,491*** [0,46 ; 0,53]
Statut matrimonial du CM	–0,130** [–0,24 ; –0,02]	–0,126*** [–0,20 ; –0,05]	–0,316*** [–0,47 ; –0,16]	–0,190*** [–0,23 ; –0,15]
Taille du ménage	0,033*** [0,02 ; 0,04]	0,028*** [0,02 ; 0,04]	0,036*** [0,02 ; 0,05]	0,027*** [0,02 ; 0,03]
Statut logement	–0,219*** [–0,30 ; –0,14]	–0,148*** [–0,21 ; –0,09]	–0,275*** [–0,40 ; –0,15]	–0,169*** [–0,20 ; –0,14]
Activité du CM	–0,805*** [–0,96 ; –0,65]	–1,068*** [–1,17 ; –0,97]	–1,451*** [–1,63 ; –1,27]	–1,013*** [–1,06 ; –0,96]
Zone Ouest	–0,287*** [–0,40 ; –0,17]	–0,070* [–0,15 ; 0,01]	0,055 [–0,14 ; 0,25]	–0,109*** [–0,15 ; –0,06]
Zone Est	–0,028 [–0,15 ; 0,09]	0,118*** [0,03 ; 0,20]	0,266*** [0,07 ; 0,46]	0,082*** [0,04 ; 0,13]
Zone Centre	0,271*** [0,17 ; 0,37]	0,331*** [0,26 ; 0,41]	0,401*** [0,23 ; 0,57]	0,307*** [0,27 ; 0,35]
Zone Sud	–0,331*** [–0,42 ; –0,24]	–0,265*** [–0,33 ; –0,19]	–0,187** [–0,34 ; –0,03]	–0,297*** [–0,33 ; –0,26]
Milieu : urbain	0,079** [0,00 ; 0,15]	0,135*** [0,08 ; 0,19]	0,189*** [0,07 ; 0,31]	0,096*** [0,07 ; 0,13]
Année 2021	–0,425*** [–0,49 ; –0,36]	–0,444*** [–0,49 ; –0,40]	–0,468*** [–0,57 ; –0,36]	–0,445*** [–0,47 ; –0,42]

Notes : Coefficients logit. IC à 95% entre crochets. * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$. Erreurs-types robustes.
Réf. : Éducation CM = aucun ; Zone = Nord ; Statut matrimonial = non marié ; Activité du CM = non actif ; Statut logement = locataire ; Année = 2018.

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

Table A.3. Balancing test des échantillons appariés : Enfants Panel

Variable	(1) Avant appariement			(2) Matching Kernel			(3) Matching 5 plus proches voisins		
	Traité	Contrôle	P-val.	Traité	Contrôle	P-val.	Traité	Contrôle	P-val.
Sexe de l'enfant (Garçon = 1)	0,473	0,504	0,000	0,473	0,473	0,996	0,473	0,482	0,009
Sexe du CM (Homme = 1)	0,729	0,908	0,000	0,729	0,735	0,090	0,729	0,716	0,000
Age du CM	47,82	44,61	0,000	47,80	47,94	0,172	47,80	47,51	0,005
Education du CM (Primaire)	0,196	0,180	0,000	0,196	0,198	0,429	0,196	0,201	0,099
Education du CM (Secondaire et plus)	0,253	0,192	0,000	0,253	0,252	0,810	0,253	0,258	0,142
Statut matrimonial du CM (Marié = 1)	0,686	0,828	0,000	0,687	0,687	0,874	0,687	0,665	0,000
Taille ménage	6,572	6,506	0,001	6,571	6,570	0,958	6,571	6,026	0,000
Occupation logement (Propriétaire = 1)	0,578	0,641	0,000	0,578	0,586	0,032	0,578	0,570	0,014
Activité du CM (Occupé = 1)	0,851	0,958	0,000	0,851	0,858	0,017	0,851	0,860	0,001
Zone Ouest (réf. : Nord)	0,134	0,153	0,000	0,134	0,137	0,288	0,134	0,135	0,906
Zone Est	0,131	0,112	0,000	0,131	0,131	0,805	0,131	0,133	0,443
Zone Centre	0,235	0,148	0,000	0,234	0,227	0,016	0,234	0,229	0,114
Zone Sud	0,311	0,360	0,000	0,312	0,312	0,887	0,312	0,309	0,521
Milieu (Urbain = 1)	0,451	0,359	0,000	0,451	0,442	0,022	0,451	0,447	0,376
Année (2021 = 1)	0,446	0,543	0,000	0,447	0,452	0,126	0,447	0,436	0,004

*Note : CM = chef de ménage. Référence éducation : aucun niveau ; référence zone : zone Nord. P-valeurs en **gras** = différences significatives au seuil de 10 % ou moins. Échantillons limités au support commun.*

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

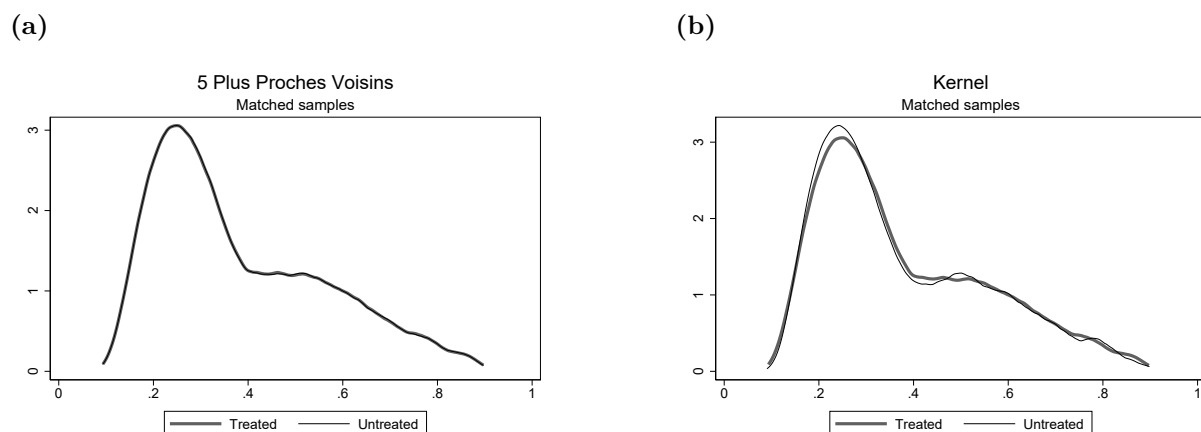
Table A.4. Test de la qualité de l'appariement : bénéficiaires vs non-bénéficiaires – enfants panel

Statistique	Avant matching	Après matching (5NN)	Après matching (Kernel)
Pseudo R^2	0,087	0,005	0,000
$p > \chi^2$	0,000	0,000	0,006
Biais moyen	17,6	2,7	0,8
Rubin's B	71,2*	17,4	4,1

* *Rubin's $B > 25$: déséquilibre résiduel significatif avant appariement.*

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

Figure A.1. Densité du score de propension après appariement : Enfants Panel



Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

Table A.5. Impact des transferts sur les indicateurs de privation : enfants panel

Méthode	Privation totale	Assain.	Eau	Logement	Santé	Education	Travail	Information	MODA ≥ 3	MODA ≥ 4
PSM	-0,070*** (0,008)	0,006* (0,003)	-0,034*** (0,003)	-0,048*** (0,003)	0,009*** (0,001)	-0,010*** (0,003)	-0,006* (0,003)	-0,035*** (0,003)	-0,031*** (0,003)	-0,031*** (0,003)
DD	-0,030 (0,060)	0,008 (0,028)	0,071** (0,030)	-0,029 (0,029)	-0,001 (0,010)	-0,032 (0,028)	0,009 (0,011)	-0,015 (0,028)	0,002 (0,027)	-0,002 (0,029)
PSM-DD	-0,151** (0,063)	-0,050* (0,029)	0,030 (0,030)	-0,078** (0,030)	-0,001 (0,010)	-0,027 (0,029)	0,007 (0,010)	-0,028 (0,031)	-0,066** (0,029)	-0,017 (0,028)

Note : Erreurs standard entre parenthèses. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. PSM = Propensity Score Matching; DD = Différence en Différences; PSM-DD = combinaison des deux méthodes.

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).

Table A.6. Effet moyen du traitement sur les traités selon l'intensité des transferts

	Priv. totale	Assain.	Eau	Logement	Santé	Éducation	Travail	Information	MODA ≥ 3	MODA ≥ 4	MODA ≥ 5	MODA ≥ 6
Intensité 1	-0,230*** (0,067)	-0,042 (0,030)	-0,036 (0,033)	-0,065** (0,033)	-0,003 (0,011)	-0,051 (0,032)	-0,013 (0,011)	-0,051 (0,033)	-0,072** (0,031)	-0,011 (0,031)	-0,049*** (0,013)	-0,004** (0,002)
Intensité 2	-0,237*** (0,077)	-0,089** (0,035)	0,040 (0,035)	-0,093*** (0,036)	0,034** (0,014)	-0,054 (0,034)	-0,007 (0,012)	0,011 (0,037)	-0,045 (0,035)	-0,169*** (0,033)	-0,055*** (0,013)	-0,005** (0,002)
Intensité 3	0,020 (0,073)	-0,008 (0,034)	0,085*** (0,033)	-0,034 (0,035)	-0,007 (0,011)	0,027 (0,032)	0,039*** (0,012)	0,023 (0,035)	-0,018 (0,033)	-0,001 (0,031)	-0,011 (0,014)	0,008* (0,004)

Note : Erreurs standard entre parenthèses. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. Intensité 1 : montant du transfert inférieur à 60 000 F CFA. Intensité 2 : montant du transfert compris entre 60 000 et 120 000 F CFA. Intensité 3 : montant du transfert supérieur à 120 000 F CFA.

Source : Calculs de l'auteure à partir des données EHCVM I (2018/2019) et EHCVM II (2021/2022).